

Pestaña 1

Estos son los módulos del programa que van a incluir para el 1er llamado o sea examen del 9 de diciembre

10-TX PERSONALIDAD

11-TX. ALIMENTARIOS

12-TX. PSICÓTICOS

13-TX. SEXUALES

Los módulos que *NO* entrarán para el 1er llamado son:

- 1- Atención y concentración
- 2- Conciencia
- 3- Juicio
- 4- Orientación
- 5- Conceptos básicos
- 6- Entrevista e historia clínica

1- AFECTIVIDAD

Función Psíquica que Impulsa y colorea toda la vida del sujeto. Es el conjunto de experiencias que definen y delimitan la vida emocional del individuo. Pueden ser Agradables y Desagradables.

MECANISMOS NEUROPSICOLÓGICOS

SISTEMA LÍMBICO: Tiene que ver con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones, personalidad y la conducta. El Sistema Límbico está formado por: Tálamo, Fondo de saco, Circunvolución Cingulada, amígdala e hipocampo.

NEUROTRANSMISORES IMPLICADOS: Noradrenalina. Serotonina y Dopamina (NA; 5HT; DA)

PSICOPATOLOGÍA

PLACENTERAS: ALEGRÍA SIMPLE EUFORIA HIPOMANÍA MANÍA ÉXTASIS BEATITUD

DISPLACENTERA : TRISTEZA ANSIEDAD MIEDO IRRITABILIDAD ANHEDONIA

PSICOPATOLOGÍA PLACENTERA

ALEGRÍA PATOLÓGICA: La alegría patológica representa una exaltación del humor que se caracteriza por un aumento del tono vital a todos los niveles. Puede ser tan intensa que el paciente pierde el control de sus impulsos y puede actuar de manera inapropiada o peligrosa.

La alegría patológica no es una emoción positiva normal, sino un síntoma de una enfermedad psiquiátrica.

EUFORIA: Estado emocional caracterizado por una sensación intensa de felicidad, excitación y bienestar. (Euforia simple o alegría desmesurada). Genera una intensidad real, que tiene una duración ilimitada y presenta consecuencias en la conducta. La euforia puede ser un efecto secundario de ciertos medicamentos. Son muy frecuentes en los trastornos Bipolares, pero también pueden presentarse en intoxicaciones por drogas, cocaína, anfetamina, éxtasis, hongos alucinógenos etc.

HIPOMANÍA: Estado de ánimo elevado, expansivo o irritable, menos severo que la manía, pero que implica un aumento anormal de la energía y la actividad. Es un estado afectivo intenso, constante y continuo, que hace que la persona sienta una inquietud psicomotriz, una alegría desmesurada, una hiperactividad física, que no influye en sus actividades diarias, es decir, los pacientes hipomaniacos son plenamente funcionales e incluso son de hecho a menudo más productivos de lo normal.

MANÍA: Estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable, acompañado de pensamientos acelerados, euforia excesiva y a menudo comportamiento impulsivo. El paciente con manía presenta una euforia desbordante que contamina todo el ambiente y que puede interferir con todo. Algunos síntomas característicos son: agitación psicomotriz, síntomas psicóticos, como los delirios de grandeza o megalomaniacos.

ÉXTASIS: Estado emocional de intensa alegría, exaltación y felicidad extrema. Estado de bienestar total, completo y absoluto que anula cualquier otro sentimiento. Estado de sensación placentera que genera una activación en la persona que la experimenta, estos estados son típicos de los generados por drogas psicotrópicas, hongos alucinógenos, polvo de ángel, etc. Se presenta con mayor frecuencia en los trastornos de tipo psicótico delirante.

OJO: el orgasmo no genera un éxtasis, solo un bienestar.

BEATITUD: Estado de placer y bienestar intenso, supremo, total, que genera una paralización. Estado de bienestar, paz y felicidad profunda, a menudo asociado con una sensación de dicha espiritual. Se presenta con frecuencia en las psicosis con delirio de tipo místico, también pueden presentarse por el uso de sustancias tóxicas como cocaína en dosis elevadas casi tóxicas, hongos alucinógenos etc.

PSICOPATOLOGÍA DISPLACENTERA

TRISTEZA PATOLÓGICA: Tristeza crónica o intensa que afecta significativamente el funcionamiento diario y que puede estar asociada con trastornos del estado de ánimo. Se presenta en los casos de depresión, trastorno de pánico, fobias, TOC

ANSIEDAD: La ansiedad se califica como patológica cuando es desproporcionada para la situación y demasiado prolongada con la consiguiente afectación del individuo, a nivel personal y social. En otras palabras; para que una ansiedad sea patológica debe tener una intensidad tan alta que interfiera con el bienestar del individuo, su duración debe ser de largo plazo y debe presentar consecuencias en la vida del individuo ya sea a nivel social, personal o laboral. Se presenta con mayor frecuencia en: Trastornos ansiosos, trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, neurosis y depresión.

MIEDO: Emoción de alarma ante una amenaza o peligro inminente. Gracias al miedo, nuestro cuerpo se prepara para hacer frente a situaciones que podrían suponer una amenaza para nuestra seguridad. Es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario.

Diferencia entre ansiedad y miedo: En la ansiedad uno tiene una sensación desagradable de malestar ante una situación o ante un objeto no percibido, la persona no puede decir que cosa le genera el malestar, sin embargo en el miedo, uno siente un estado de malestar intenso en el cual puede identificar perfectamente la situación que genera el cuadro.

Ejemplo: Fobia al perro, la fobia sería el miedo patológico y el perro sería el objeto motivo identificado.

IRRITABILIDAD: Estado de ánimo caracterizado por respuestas exageradas o excesivas frente a estímulos irritantes o situaciones estresantes. Es un estado displacentero que genera un malestar que casi siempre se acompaña con reactividad psicomotora y alteración de conducta y sobre todo de relacionamiento, es típico de los pacientes en estado de abstinencia por alcohol, drogas, cocaína, anfetamina, marihuana. También se presenta en pacientes psicóticos y en los trastornos de personalidad.

ANHEDONIA: Es la disminución o la desaparición de la capacidad para obtener placer en circunstancias que con anterioridad sí lo procuraban. Es uno de los síntomas depresivos por excelencia.

OTRAS PSICOPATOLOGÍAS

- TENACIDAD
- LABILIDAD
- INCONTINENCIA
- AMBIVALENCIA
- APLANAMIENTO AFECTIVO
- PERPLEJIDAD
- NEOTIMIAS
- ALEXITIMIA

TENACIDAD: Consiste en la persistencia durante un tiempo extremadamente prolongado de una emoción determinada, condicionando así por un período demasiado largo el estado afectivo del sujeto. Es decir, persiste el mismo estado anímico aunque ya no sea para nada útil o no sea para nada adaptativo. Se presenta con mayor frecuencia en el autismo y retraso mental.

LABILIDAD AFECTIVA: Cambio brusco del estado de ánimo ya sea de agradable a desagradable, o de desagradable a agradable sin ningún motivo determinado. El paciente cambia bruscamente de afecto sin motivo alguno. La labilidad emocional dura casi siempre poco tiempo (segundos-minutos), aunque puede reaparecer varias veces en el mismo paciente. Se presenta con mayor frecuencia en: Psicosis, Tx. Depresivos, Tx de personalidad.

INCONTINENCIA AFECTIVA: Cambio brusco de polaridad afectiva, ya sea de agradable a desagradable, pero siempre existe un motivo determinado.

Estado emocional que se caracteriza por la incapacidad para controlar las manifestaciones afectivas, aunque se intente de forma consciente. La persona hace esfuerzos para no manifestar su tristeza, pero termina por estallar en sollozos o llorar sin consuelo. Se observa habitualmente en la depresión, en la demencia, y en algunos trastornos de ansiedad, también en situaciones de duelo, intoxicaciones y cuadros psicóticos, trastornos de la personalidad de tipo histriónico y narcisista

AMBIVALENCIA AFECTIVA: Se denomina ambivalencia de sentimientos la coexistencia de sentimientos positivos y negativos con respecto a un mismo objeto, contenido vivencial o representación. Es decir, dos afectos contrapuestos uno a otro, hacia una misma persona en un mismo momento. Típico de la esquizofrenia

APLANAMIENTO AFECTIVO: Consiste en la imposibilidad del sujeto de reaccionar ante los objetos, situaciones y personas.

Quienes lo padecen, presentan incapacidad afectiva y, por lo tanto, incapacidad de expresar las emociones verbalmente. El paciente tiene una falta total de tonalidad afectiva o de resonancia emocional en forma constante, ejemplo: uno puede hablar del cumpleaños de un amigo y al rato cambiar de tema y hablar del fallecimiento de un ser querido con la misma tonalidad, no existe cambio alguno.

PERPLEJIDAD: Estado de extrañeza o extrañamiento afectivo como si uno no estuviera entendiendo la situación que está pasando. Estado afectivo caracterizado por angustia, extrañeza y asombro frente a situaciones extrañas o nuevas. Típico de los cuadros disociativos, uso de sustancias, éxtasis, cocaína y morfina.

NEOTIMIAS: Las neotimias se pueden clasificar como estados afectivos de excepción, ya que la carga afectiva es de tal intensidad que apenas se llega a una configuración individual de la reacción a través de la personalidad.

Ejemplo: el paciente tiene un afecto que solo él puede identificar, como si fuera que uno inventara ese afecto, solo tiene significancia para ese paciente, o, un afecto que el paciente puede llamar como una alegría, para él es una tristeza o sea le da un valor distinto. Típico de los trastornos psicóticos y retrasos mentales.

ALEXITIMIA: La alexitimia puede definirse como la incapacidad para percibir sentimientos o expresar e identificar los propios.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

La exploración de la afectividad se basa en datos subjetivos referidos por el paciente en cuanto a sentimientos, estado de ánimo, afectos o emociones predominantes, aunque sin obviar aspectos más objetivos como la apariencia externa, la conducta motora, la expresividad o la actitud durante la entrevista. Por medio de las entrevistas y la empatía evaluando su humor a través del lenguaje tanto verbal como corporal y la coherencia entre ambos, así como el contenido del pensamiento.

2. ANSIEDAD

¿QUÉ ENTENDEMOS POR LA ANSIEDAD?

- Se trata de la anticipación de un peligro (físico y/o emocional) que amenaza al sujeto y que le pone en estado de alerta (dimensión cognitivo-emocional) y de tensión (dimensión fisiológica).
- Es experimentada por el sujeto como algo contra lo que no puede luchar y lo lleva a poner en marcha una conducta de evitación.
- Estas reacciones debemos entenderlas como normales y adaptativas, ya que no podemos vivir sin ansiedad.
- La ansiedad es el síntoma psicopatológico más común en los trastornos psiquiátricos en la población general.
- Su frecuencia en las mujeres duplica a la de los varones.

¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD?

- Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño laboral, académico e interpersonal.
- Los trastornos de ansiedad resultan de la interacción existente entre los factores psicológicos, biológicos y sociales.
- No se conoce la causa exacta de la ansiedad. Factores como la genética, la biología y química del cerebro, el estrés y su entorno pueden tener un rol.

ANSIEDAD NORMAL VS ANSIEDAD PATOLÓGICA

- **ANSIEDAD NORMAL:** episodios poco frecuentes, intensidad leve o media, duración limitada, reacción esperable y común, sufrimiento limitado y transitorio, consecuencias ausentes o ligeras.
- **ANSIEDAD PATOLÓGICA:** episodios repetidos, intensidad alta, duración prolongada, reacción desproporcionada, sufrimiento alto y duradero, consecuencias graves y profundas.

¿CÓMO DIFERENCIAR UN ATAQUE DE ANSIEDAD DE LA ANSIEDAD NORMAL?

- El ataque de ansiedad se diferencia de la ansiedad normal, en que la intensidad de los síntomas es mucho mayor y el tiempo de instauración es muy breve.
- En pocos minutos, la crisis de ansiedad alcanza un pico máximo de intensidad; mientras que, en la ansiedad continua, esta es más estable en el tiempo y sus fluctuaciones son mucho más lentas.

ANSIEDAD NORMAL

- **ANSIEDAD y MIEDO** son señales de alerta, advierten de un peligro inminente y permiten al individuo adoptar medidas para afrontar la amenaza.

MIEDO

Reacción normal ante situaciones de peligro identificable en el ambiente (amenaza externa, conocida).

Siempre existe objeto.

No conflictiva.

ANSIEDAD

Respuesta de amenaza anticipada (amenaza interna, muchas veces desconocida).

No se acompaña de objeto.

Vaga o no conflictiva.

SÍNTOMAS COGNITIVOS DE LA ANSIEDAD

- Preocupación excesiva.
- Inseguridad, miedo o temor.
- Pensamientos negativos.
- Pensamientos de anticipación al futuro, con miedo al devenir y a la incertidumbre.
- Pensamientos recurrentes de miedo a que aparezcan los síntomas físicos, anticipándolos.
- Anticipación de peligro.
- Dificultad para mantener la atención y concentración, bajando significativamente la capacidad de memoria.
- Dificultad para la toma de decisiones.
- Sensación de desorganización o pérdida de control.

SÍNTOMAS MOTORES U OBSERVABLES DE LA ANSIEDAD

- Hiperactividad, agitación o inquietud psicomotriz.
- Temblores, tics, fibrilación, mioclonías.
- Paralización motora.
- Movimientos torpes y desorganizados.
- Tartamudeo.
- Conductas de evitación.
- Crisis de llanto.
- Fumar, comer o beber en exceso.

SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS DE LA ANSIEDAD

- Cardiovasculares: Palpitaciones, hipertensión, opresión precordial, sensación de paro cardíaco.
- Respiratorio: Sensación de sofoco, falta de aire, ahogo, respiración rápida y superficial.
- Gastrointestinales: Náuseas, vértigos, vómitos, diarrea, aerofagia, dispepsias.
- Genitourinarios: Urgencia miccional, enuresis, eyaculación precoz, frigidez, impotencia.
- Neuromusculares: Temblor, tensión muscular, hormigueo, cefalea tensional, fatiga excesiva.
- Neurovegetativos: Sequedad de boca, sudoración excesiva, mareos, sudoración fría, manos y pies fríos, parestesias.

PREVALENCIA

- Se estima que alrededor del 25% a 35% de la población mundial experimentará en alguna ocasión un trastorno de ansiedad.
- Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más comunes (Can Psych Assoc, 2006).
- Según la OMS, en atención primaria en la población adulta hay una prevalencia del 12%.
- Inician tempranamente (media: 15 años) y alcanzan mayor prevalencia entre los 25 y 45 años, más en mujeres.
- Según la OPS, los trastornos de ansiedad más frecuentes son: TAG, TOC y Trastorno de Pánico.

COMORBILIDAD

- Abuso de sustancias.
- Trastorno de la personalidad.
- Trastornos depresivos.

TIPOS DE TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD

1. Crisis de angustia (pánico)
2. Agorafobia
3. Trastorno de ansiedad generalizada
4. Fobias (específica y social)
5. Trastorno por estrés postraumático
6. Trastorno obsesivo compulsivo
7. Trastorno de ansiedad por separación
8. Mutismo selectivo
9. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos
10. Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica

CRISIS DE ANGUSTIA (PÁNICO)

- Episodio repentino de miedo o malestar intenso que alcanza máxima intensidad en minutos (15 a 30 min).
- Luego aparece una calma y desaparece.

Síntomas característicos:

- ✓ Palpitaciones, sudoración, temblores.
- ✓ Sensación de falta de aliento o asfixia.
- ✓ Dolor o malestar en el pecho.
- ✓ Mareo o vértigo.
- ✓ Náuseas o malestar abdominal.
- ✓ Miedo a perder el control o “volverse loco”.
- ✓ Miedo a morir.
- ✓ Sensación de irrealidad (desrealización) o despersonalización.

AGORAFOBIA

- Miedo intenso a situaciones donde escapar podría ser difícil o no habría ayuda.
- Provoca evitación o gran malestar.

Síntomas característicos:

Miedo o ansiedad en al menos dos de estas situaciones:

- ✓ Uso de transporte público.
- ✓ Espacios abiertos (plazas).
- ✓ Lugares cerrados (tiendas, cines).
- ✓ Multitudes o filas.
- ✓ Estar fuera de casa solo.
- Evitación marcada.
- Miedo desproporcionado.
- Malestar o deterioro significativo.

OBS: Frecuentemente asociada al trastorno de pánico.

TRASTORNOS DE ANSIEDAD

T. Angustia:

- a) crisis inesperadas,
- b) preocupación por las crisis,
- c) cambio conductual.

Agorafobia:

- a) Ansiedad ante lugares difíciles de escapar,
- b) Se evitan dichas situaciones.

TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (TAG)

- Preocupación excesiva e incontrolable durante al menos 6 meses.

Síntomas:

- Ansiedad persistente.
- Dificultad para controlar la preocupación.
- Inquietud.
- Fatiga, irritabilidad, tensión muscular.
- Dificultad para concentrarse o mente en blanco.
- Problemas de sueño.

FOBIAS (ESPECÍFICA Y SOCIAL)

FOBIAS ESPECÍFICAS

- ✓ Miedo intenso y persistente a un objeto o situación específica.
- ✓ Respuesta inmediata de ansiedad patológica.
- ✓ Puede desencadenar ataques de pánico.

FOBIA SOCIAL

- ✓ Miedo intenso a situaciones sociales donde se teme evaluación negativa.
- ✓ Evitación frecuente.

TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT)

- Aparece luego de un evento traumático.

Síntomas:

- Recuerdos intrusivos.
- Pesadillas.

- Flashbacks (ecmnesia).
- Evitación.
- Culpa, vergüenza, desesperanza.
- Hipervigilancia, irritabilidad, sobresaltos.

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (TOC)

- Obsesiones = pensamientos intrusivos.
- Compulsiones = actos repetitivos para reducir ansiedad.

Síntomas:

- Obsesiones recurrentes.
- Compulsiones excesivas.
- No son realistas o son excesivas.
- Consumen tiempo (>1 h/día) y afectan la vida diaria.

TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

- Ansiedad excesiva al separarse de figuras de apego.
- Síntomas: Angustia anticipatoria, miedo a perder a la persona, pesadillas, síntomas físicos.

MUTISMO SELECTIVO: Incapacidad para hablar en situaciones sociales específicas, pese a hacerlo en otras.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (DSM-5)

Trastorno de ansiedad por separación

- A. Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada.
- B. Duración: ≥ 4 semanas en niños / ≥ 6 meses en adultos.

Mutismo selectivo

- A. Fracaso constante de hablar en determinadas situaciones.
- B. Interfiere con logros educativos, laborales o sociales.

TRASTORNO DE ANSIEDAD INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS

- Ansiedad provocada por consumo o abstinencia.

TRASTORNO DE ANSIEDAD DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA

- Ansiedad atribuida a enfermedad médica.

DIFERENCIA ENTRE CRISIS DE PÁNICO Y TRASTORNO DE PÁNICO

CRISIS DE PÁNICO

- Episodio súbito e intenso de miedo.
- Duración de minutos.
- Puede ser aislado.

TRASTORNO DE PÁNICO

- Crisis recurrentes.
- Preocupación persistente por nuevas crisis.
- Cambio conductual por evitación.
- Duración mínima: 1 mes.
- Afecta significativamente la vida diaria.

3- LENGUAJE

LENGUAJE: Es la función mental por la que un emisor transmite a un receptor códigos predeterminados. Es la herramienta que permite expresar las emociones, pensamientos, ideas y sentimientos que experimentan las personas, posibilitando la comunicación entre estas, haciendo que sea un instrumento fundamental para el ser humano.

MECANISMOS Neuropsicológicos DEL LENGUAJE

a) Áreas del lenguaje en el cerebro:

- Área Motora (Expresión) Prefrontal o Área 41 de Broca.
- Área Sensorial (Comprensión) 3º Circunvolución Temporal.
- Área de Asociación.
- Área Orolinguofacial.

b) Conexiones neuronales.

c) Funciones cognitivas superiores.

d) Plasticidad cerebral.

TIPOS DE LENGUAJE

- ORAL
- ESCRITO
- MIMICO (EXPRESIVO)

PSICOPATOLOGÍA DEL LENGUAJE

El trastorno del lenguaje es definido como el deterioro o desarrollo deficiente de la comprensión y utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología, sintaxis, la semántica y la pragmática.

1- PSICOPATOLOGÍA DEL LENGUAJE ORAL

AFASIAS

MOTORA O DE EXPRESIÓN: La alteración se presenta en la fluidez, la expresión; sin embargo, está conservada la comprensión del lenguaje.

El paciente puede comprender lo que le hablan, pero no puede expresarse.

SENSITIVA O DE COMPRENSIÓN: Está afectada la comprensión del lenguaje, pero está conservada la expresión o fluidez.

El paciente puede expresarse pero no puede comprender lo que dice ni lo que se le dice.

MIXTA: Afecta tanto la producción como la comprensión del lenguaje.

Los pacientes pueden tener dificultades para encontrar las palabras correctas al hablar, así como para entender el lenguaje hablado o escrito.

DISARTRIA: Trastorno del habla causado por daño cerebral o lesiones que afectan los músculos para hablar; causa dificultad en la articulación.

DISFONÍAS: Trastornos de la voz que modifican calidad, volumen o tono.

DISLALIAS: Trastornos del habla que implican dificultades en la pronunciación de ciertos fonemas.

DISGLOSIA: Trastorno de la pronunciación causado por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla de origen no neurológico. También llamada dislalia orgánica.

NEOLOGISMO: Creación de nuevas palabras o expresiones que pueden no tener significado para los demás.

TICS: Movimientos o sonidos repetitivos e involuntarios característicos de algunos trastornos neuropsiquiátricos.

LOGOCLONIA: El paciente repite la última sílaba de las palabras de forma compulsiva.

MUTISMO: Falta total de emisión de palabras sin daño orgánico.

Incapacidad persistente para hablar en situaciones en las que se espera que se hable.

Relacionado con ansiedad social, trastornos del desarrollo, cuadros conversivos, trastornos de personalidad.

MUSITACIÓN: El paciente murmura; los sonidos no son audibles para el receptor, son suaves e incomprensibles. Parece hablar consigo mismo.

MONÓLOGO: Discurso largo y continuo de una sola persona, sin interacción con otros.

COPROLALIA: Uso de palabras groseras, soeces o de mal hablar.

JERGAFASIA: Uso de lenguaje ininteligible o distorsionado.

ECOLALIA: Repetición involuntaria o automática de palabras o frases de otros.

El paciente repite la última palabra o terminación de la última palabra que dice el entrevistador.

Ocurre en esquizofrenia hebefrénica, esquizofrenia residual, autismo, retraso mental.

TAQUILALIA: Hablar muy rápido.

Dificulta al receptor seguir el discurso.

Sinónimo: verborrea, verborragia, logorrea.

Asociado a ansiedad, agitación psicomotriz, hipomanía.

BRADILALIA: Hablar muy lento, dificultando la comprensión por falta de conexión fluida entre ideas.

Aparece en depresión, traumatismos craneales, intoxicaciones.

TARTAMUDEZ / DISFEMIAS / ESPASMOFEMIA: Trastorno del ritmo del habla.

Prolongación o repetición de sonidos o sílabas.

Se agrava con ansiedad. Puede acompañarse de sudoración y rubefacción facial.

ESTEREOTIPIA VERBAL: Repetición involuntaria de movimientos, palabras, ideas o pensamientos.

El paciente repite palabras o frases sin relación con el discurso.

Aparece en psicosis: esquizofrenia residual, retardo mental, autismo, meningitis, H1N1.

SOLILOQUIOS: El paciente habla en solitario como si estuviera conversando con alguien.

Puede ser normal (para pensar, decidir) o patológico (delirio, alucinaciones, daño cerebral).

PSICOPATOLOGÍA DEL LENGUAJE ESCRITO

DISGRAFIA: Trastorno de la escritura con dificultad para escribir de manera clara y legible.

AGRAFIA: Pérdida de la capacidad de escribir por daño cerebral.

ALEXIA: Pérdida de la capacidad de comprender el lenguaje escrito.

PSICOPATOLOGÍA DEL LENGUAJE EXPRESIVO O MÍMICA

HIPERMIMIA: Exageración de expresión facial o lenguaje no verbal.

El paciente exagera mímica facial para expresar emociones o comunicar algo.

HIPOMIMIA: Reducción notable de la expresión facial.

Pobreza de demostraciones no verbales.

Puede acompañarse de aplanamiento afectivo.

PARAMIMIAS: Gestos o expresiones faciales inapropiados o desacompañados con el habla.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

Explorando cada uno de los lenguajes por separado de forma activa y pasiva, evaluando la coherencia entre uno y otro.

4- MEMORIA

Es la actividad psíquica que permite fijar, conservar y evocar, previo reconocimiento, las vivencias que la han impresionado. El objetivo de la memoria es la continuidad de la vida psíquica por ser nexo entre el pasado y presente.

FASES DE LA MEMORIA

FIJACIÓN: Implica la codificación inicial de la información a través de la percepción sensorial y su transferencia a la memoria a corto plazo.

Es la capacidad de mantener la información por un tiempo determinado.

Esta fijación es de corto tiempo de 3 a 15 min y después pasa al olvido.

CONSERVACIÓN: Involucra la retención a largo plazo de la información almacenada en la memoria, a través de procesos de consolidación.

En esta fase los eventos de la memoria son transformados en un sistema proteico, el cual puede mantener lo almacenado en la memoria por meses, años y hasta toda la vida.

RECONOCIMIENTO: Se refiere a la habilidad de identificar información previamente aprendida cuando se presenta de nuevo, como reconocer a alguien conocido.

Es el proceso por el cual la función psíquica va reconociendo la huella mnésica.

EVOCACIÓN: Consiste en la recuperación consciente y activa de información almacenada en la memoria, como recordar una lista de compras.

Proceso por el cual se identifica y se localiza la memoria.

OLVIDO: Es un sistema por el cual se elimina información innecesaria y de poco uso.

– Proceso de extinción de la memoria.

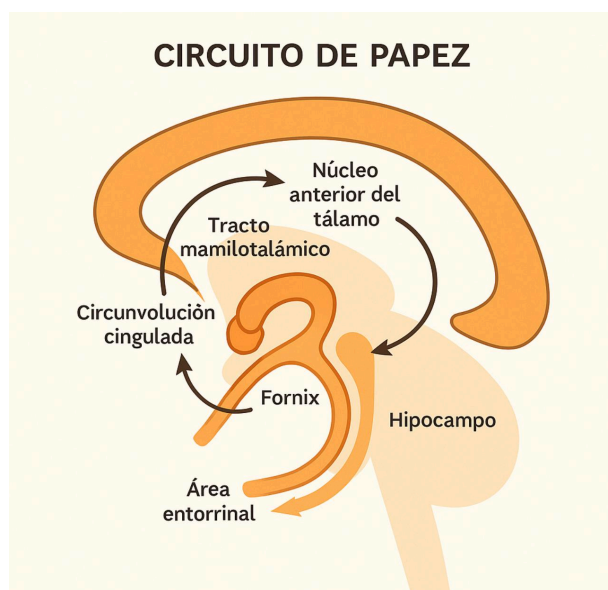
LEY DE RIBOT: Primero se olvida lo último que se aprendió.

Los recuerdos se pierden, según la ley de Ribot, en orden inverso a su adquisición.

MECANISMOS NEUROPSICOLÓGICOS

CORTO PLAZO: (Anterógrada, de fijación o reciente)

Circuito de Papez: Hipocampo unido por el Fórnix al Cuerpo Mamilar unido por el Fascículo Mamilotalámico al Girus Cinguli conectado por el Cíngulo a la Región Entorrinal y este de nuevo con el Hipocampo por el Fascículo Perforante.



LARGO PLAZO: (Retrógrada, de conservación o tardía)

R.N.A.: Proteína específica que forma las membranas de las neuronas donde se van desarrollando y depositando las huellas mnésicas, para luego ser reconocido y evocado.

Psicopatologías de la MEMORIA

AMNESIAS: PARCIALES — TOTALES — ANTERÓGRADAS — RETRÓGRADAS — RETROANTERÓGRADAS O MIXTAS

AMNESIAS PSICÓGENAS:

A. AFECTIVAS

A. ANSIOSAS

A. DISOCIATIVAS

A. CATÁRTICAS

HIPOMNESIAS

HIPERMNESIAS

PSICOPATOLOGÍAS DE LA MEMORIA – AMNESIAS

Amnesia Parcial: Se refiere a la pérdida de memoria selectiva o de ciertos eventos, períodos de tiempo o aspectos específicos de la memoria. (Demencia, cuadros depresivos, procesos ansiosos)

Amnesia Total: Implica una pérdida completa de la memoria, tanto de experiencias pasadas como de memoria a corto plazo.

Este tipo de amnesia es inusual y generalmente es el resultado de daño cerebral extenso.

Amnesia Anterógrada: Se caracteriza por la incapacidad de formar nuevos recuerdos después de un evento traumático o daño cerebral.

Las personas con amnesia anterógrada pueden recordar eventos pasados, pero no pueden retener nueva información.

Amnesia Retrógrada: Se refiere a la incapacidad para recordar eventos pasados antes de un evento traumático o una lesión, lo que resulta en un vacío en la memoria previa al evento.

Amnesia Retroanterógrada: En este tipo de amnesia, se ve afectada tanto la memoria anterior al evento traumático como la capacidad de formar nuevos recuerdos.

AMNESIAS PSICÓGENAS

AMNESIA AFECTIVA: Se caracteriza por la incapacidad para recordar detalles emocionales significativos, comúnmente asociados a eventos traumáticos.

AMNESIA ANSIOSA: Ocurre como resultado del estrés extremo o de un trastorno de ansiedad, lo que provoca una interrupción temporal en la capacidad de recordar eventos recientes o pasados.

Amnesia Disociativa: Pérdida de memoria causada por fenómenos disociativos, vinculados a traumas severos.

Se divide en dos tipos:

Fuga Histórica: Pérdida repentina y objetiva de la identidad, acompañada de una partida inesperada del hogar, trabajo u otros entornos.

Hay imposibilidad de recordar el pasado. Puede asumir nueva identidad.

Es reversible y ocurre por estrechamiento de la conciencia.

Amnesia Histórica: Implica pérdida temporal y selectiva de memoria vinculada a información personal o experiencias traumáticas.

Puede incluir incapacidad de recordar eventos específicos, periodos de tiempo, identidades alternas o aspectos significativos de la vida.

En resumen: desaparece toda la biografía y se vive una nueva vida.

Amnesia Catártica: Aparece en respuesta a eventos traumáticos, donde la persona olvida temporalmente el evento como mecanismo de protección emocional.

Hipomnesia: Disminución en la capacidad de retención de información, con dificultad para recordar eventos pasados o nueva información.

Hipermnesia: Recuperación intensa y detallada de recuerdos, a menudo asociada a eventos traumáticos o situaciones altamente emocionales.

- FENÓMENO DE LO YA VISTO (DEJA VÚ)
- FENÓMENO DE LO NUNCA VISTO (DEJAMÉ VÚ)
- ILUSIÓN DE LA MEMORIA
- ALUCINACIÓN DE LA MEMORIA
- CRIPTOMNESIAS
- ECMNESIAS (**flashback**)
- AMNESIAS LACUNAR

FENÓMENO DE LO YA VISTO: Percepción de que un evento o situación ya fue vivido cuando en realidad es la primera vez.

FENÓMENO DE LO NUNCA VISTO: Percepción de una situación como nueva, a pesar de haber sido vivida anteriormente.

Ilusión de la memoria: Percepción errónea de eventos pasados, producto de distorsión o mala interpretación. Puede ser influida por sugerencias externas, emociones, tiempo.

Alucinación de la memoria: Percepción de experiencias pasadas que nunca ocurrieron (contenido psicótico o delirante).

Criptomnesia: Creencia falsa de originalidad de una idea olvidada previamente; la persona no reconoce que está recordando.

ECMNESIA: Reexperimentación de recuerdos con tal detalle que se sienten actuales.

AMNESIA LACUNAR: Pérdida de memoria de eventos específicos, generando lagunas.

Generalmente de origen orgánico, frecuente en consumo de tóxicos.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

TARDÍA: Interrogar sobre hechos comprobables de la niñez o de mucho tiempo.

RECIENTE: Se nombran cinco números o tres objetos, se distrae al paciente y se solicita que lo repita en quince minutos.

5- PENSAMIENTO

DEFINICIÓN DE PENSAMIENTO

Es la función psíquica por la cual las ideas se asocian para formar un concepto central.

El concepto de pensamiento hace referencia a procesos mentales, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo.

Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento, relacionándose entre sí.

Mecanismos neuropsicológicos del pensamiento

1. Redes Neuronales y Conectividad.
2. Áreas Cerebrales Claves:
 - Corteza Prefrontal: Responsable de las funciones ejecutivas como la planificación, toma de decisiones, razonamiento y control de impulsos.
 - Corteza Parietal: Involucrada en la integración de información sensorial y espacial.
 - Corteza Temporal: Participa en el procesamiento del lenguaje y la memoria.
 - Corteza Occipital: Involucrada en el procesamiento visual.
 - Hipocampo: Fundamental para la formación y recuperación de la memoria.
3. Neurotransmisores
 - Dopamina: Asociada con la motivación, recompensa y toma de decisiones.
 - Serotonina: Relacionada con el estado de ánimo, la memoria y la cognición.
 - Glutamato: Principal neurotransmisor excitatorio, crucial para la plasticidad sináptica y la memoria.
 - GABA (ácido gamma-aminobutírico): principal neurotransmisor inhibitorio, ayuda a regular la excitación neuronal.
4. Plasticidad neuronal.

COMPONENTES DEL PENSAMIENTO

Todo pensamiento tiene:

- 1- Curso o flujo (Velocidad del pensamiento)
- 2- Contenido (Unión de una idea central más ideas accesorias)
- 3- Forma (Cómo se unen o canalizan las ideas entre sí para formar el concepto)

Tipos de pensamiento

1) PENSAMIENTO MÁGICO: Es la creencia de que ciertos pensamientos pueden influir en eventos externos de manera poco realista.

Son explicaciones basadas en la magia y fantasía, que contradicen a las leyes naturales, carecen de sustento científico y cumplen la función de reducir la ansiedad asociada con los eventos impredecibles del mundo.

Se fundamenta en creencias cuya estructuración no sigue un patrón racional.

Suele estar basado en percepciones psíquicas subjetivas del individuo/colectivo, pudiendo haber sido influenciado por otras personas que conocen o aceptan de algún modo dichas teorías o creencias.

Se da en el TOC, en el juego patológico, en algunas esquizofrenias y también en algunos sujetos normales.

2) PENSAMIENTO CONCRETO: Es el que nos permite procesar y describir los objetos del mundo físico.

Se refiere a la información; la persona recibe información a través de los sentidos.

Se centra en el presente y en lo tangible, exige procesamiento mental.

Ejemplos: objetos reales como mesas, sillas, plátanos, manzanas o incluso números.

3) PENSAMIENTO ABSTRACTO: Es una facultad del ser humano que posibilita la creación de ideas, imaginar sucesos, planificar soluciones y proyectarse al futuro.

Se refiere a las ideas.

Es la capacidad de narrar historias, modelar procesos, leer e interpretar problemas y planificar soluciones.

Permite crear ideas originales y anticiparse a escenarios.

Es una capacidad exclusivamente humana.

PSICOPATOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

A) CURSO, flujo o velocidad del pensamiento:

- Taquipsiquia
- Bradipsiquia
- Fuga de Ideas
- Pensamiento Circunstancial
- Interceptación del Pensamiento
- Difusión del Pensamiento
- Robo del Pensamiento

- Estereotipia del Pensamiento
- Pensamiento Perseverante
- Pensamiento Tangencial

A) CURSO, flujo o velocidad del pensamiento:

Taquipsiquia: Trastorno caracterizado por aceleración anormal de la velocidad del pensamiento. Aumenta la producción de ideas y dificulta mantener un hilo lógico.

Típico de los trastornos hipomaniacos, intoxicaciones por cocaína, cafeína, anfetaminas.

Bradipsiquia: Disminución significativa en la velocidad del pensamiento y en la capacidad para generar ideas.

Típica de cuadros depresivos y del uso de tóxicos como marihuana y sedantes.

Fuga de Ideas: Rápida sucesión y desbordamiento de ideas no relacionadas.

Dificulta la coherencia y la comunicación lógica.

Una idea aparece antes de que concluya la anterior.

Típico: trastornos maniacos, consumo de anfetamina y cocaína.

Pensamiento Circunstancial: Respuestas excesivamente detalladas, desviaciones innecesarias, dificultad para llegar al punto principal.

Frecuente en personalidad obsesiva, retraso mental, epilepsia.

Bloqueo del pensamiento / Interceptación del pensamiento: Interrupción súbita del flujo del pensamiento.

Duración variable: segundos a horas.

Característico de esquizofrenia hebefrénica o paranoide.

Difusión del pensamiento: Falta de coherencia, ideas desorganizadas y desconectadas.

El paciente cree que sus pensamientos son conocidos por otros, llegando a ellos por telepatía o mecanismos externos.

Característico de esquizofrenia.

Robo del pensamiento: Sensación de que los pensamientos han sido eliminados o influidos por una fuerza externa.

Típico de trastornos paranoides o esquizofrenia paranoide.

Estereotipia del pensamiento: Repetición inflexible y mecánica de un pensamiento, frase o acción.

Interfiere con la idea central.

Se presenta en trastornos obsesivos, psicóticos y orgánicos.

Pensamiento Perseverante: Repetición de la misma respuesta ante diferentes preguntas.

No logra cambiar el marco de referencia.

Aparece en esquizofrenia, demencias, alteraciones prefrontales.

Pensamiento Tangencial: Incapacidad de asociar ideas hacia un objetivo.

No responde directamente lo preguntado.

Se pierde en divagaciones inducidas por estímulos irrelevantes.

B) CONTENIDO del pensamiento:

1) Ideas Delirantes: Creencias falsas e infundadas que no se ajustan a la realidad y no están sujetas a razonamiento lógico.

Se dividen en:

- Paranoides
- Megalomaníacos
- Místicos
- Nihilistas
- Depresivos

2) Ideas Obsesivas: Pensamientos intrusivos, parásitos, persistentes y no deseados que generan ansiedad y malestar significativos.

Pueden ser ideas, temores, imágenes o impulsos repetitivos, no deseados e irracionales para el paciente.

3) Ideas Fijas: Pensamientos, imágenes o impulsos no deseados y repetitivos que invaden la mente de una persona, causando malestar significativo e interfiriendo con la vida diaria.

4) Ideas Sobrevaloradas: Creencias intensas y preconcebidas que dominan pensamiento y conducta.

La idea se ve contaminada por la pasión.

Ocupan un lugar central en la vida, con marcado tono afectivo.

Ejemplo: fanático de un club que mata a otro, o alguien de un grupo político.

5) Ideas Depresivas: Creencias negativas y distorsionadas propias de trastornos del estado de ánimo.

Pueden ser ideas de minusvalía, ruina, culpa y suicidas.

IDEAS DELIRANTES O DELIRIOS

1) PARANOIDE

a) Persecución: Creencia firme de conspiración o persecución, vigilancia u observación por personas, entidades u organizaciones.

b) Daño: Creencia sin base real de estar siendo maltratado, perjudicado o en riesgo de daño físico o enfermedad provocada por otros.

c) Erotomaniaco: Creencia de que una persona, generalmente de nivel social, cultural o económico superior, está locamente enamorada del paciente.

Suele tratarse de figuras públicas: locutores, políticos, cantantes, presidentes.

Presente en: trastorno paranoide, esquizofrenia paranoide y catatónica, depresión psicótica, trastorno delirante persistente o primario.

d) Celotípico: Delirio centrado en la creencia de infidelidad por parte de la pareja.

Ninguna evidencia objetiva cambia su convicción absoluta.

Busca constantemente indicios de infidelidad.

DIFERENCIAS ENTRE: CELO NORMAL, CELO PATOLÓGICO Y CELOTIPIA

Celo Normal: Sentimiento de inquietud o inseguridad ante amenaza percibida hacia la relación.

Es razonable, manejable, surge de situaciones reales y no interfiere significativamente en la vida diaria.

Celo Patológico: Creencia delirante infundada de infidelidad, no modificable con pruebas objetivas.

Forma extrema e irracional de celos, con pensamientos y conductas obsesivas; asociada a trastornos psicológicos.

Celotipia: Irracional y obsesiva, basada en pensamientos no fundamentados y persistentes.

Deteriora la relación y la calidad de vida.

2) Megalomaniaco: También llamado delirio de grandeza.

El paciente cree poseer habilidades, poderes especiales, ser muy importante o tener grandes bienes.

Propio de episodios maníacos y algunas esquizofrenias.

3) Místico: Contenido delirante de temática religiosa.

Creencia de revelaciones espirituales especiales.

El paciente puede creer que cumple misiones divinas, ser un líder universal o una divinidad.

Típico de esquizofrenias (todos los tipos).

4) Nihilista: Llamado también delirio de negación.

Creencia de que uno mismo, los demás o el mundo han dejado de existir.

El paciente puede creer que está muerto, vacío, sin vísceras.

Incluye síndrome de Cotard.

Típico de esquizofrenia hebefrénica y simple.

5) Delirio de Capgras o Ilusión de Sosias: Creencia de que personas significativas han sido reemplazadas por dobles idénticos.

El paciente piensa que las personas no son realmente quienes parecen ser, sino impostores.

Es un trastorno de falsa identificación.

6) Depresivos

a) Culpa: Convicción inamovible de haber hecho algo imperdonable.

El paciente se siente responsable de todo lo negativo que les ocurre a él y a los demás; cree merecer castigo.

b) Ruina: Cree que ha perdido todas sus posesiones materiales, asegurando estar en pobreza absoluta.

c) Pobreza: Creencia errónea de estar en pobreza extrema o a punto de perder todos los recursos, aunque no sea cierto.

2- IDEAS OBSESIVAS U OBSESIONES

1) Contaminación: Preocupaciones excesivas por suciedad, gérmenes o contaminación.

Lleva a evitar lugares y actividades; compulsiones como lavarse repetidamente.

2) Orden y simetría: Necesidad de que las cosas estén en un orden específico o alineadas.

Compulsiones: reorganizar objetos hasta lograr “perfección”.

3) Dudas: Pensamientos recurrentes de duda sobre acciones como cerrar la puerta o apagar la luz.

Llevan a repetir la acción para estar seguro.

4) Sexuales: Ideas intrusivas y no deseadas sobre actos sexuales inapropiados.

Generan gran angustia.

5) Daño o pérdida de control: Miedo persistente a causar daño a otros o perder control y cometer actos dañinos.

6) Coprolálicas: Necesidad compulsiva de decir palabras obscenas o inapropiadas.

7) Acumulativas: Compulsión de acumular objetos sin utilidad aparente.

Ansiedad intensa al intentar descartarlos.

C) FORMA DEL PENSAMIENTO:

1) Condensación: Dos ideas accesorias con algo en común se unen para formar un concepto erróneo.

Ejemplo: “las sillas verdes de la sala, las sillas verdes del parlamento → estamos en el parlamento.”

2) Desplazamiento: Una idea central es desplazada por una idea accesoria, formando un concepto erróneo.

3) Uso Anormal De Símbolos: Un símbolo o código que para todos tiene un significado concreto, el paciente lo reemplaza por otro que no corresponde.

Ejemplo: llamar “silla” a una mesa.

Se presenta en trastornos psicóticos (orgánicos o no).

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

Por medio de la entrevista psicopatológica, prestando especial atención al contenido del lenguaje oral y mímico, así como la observación de su conducta.

Se debe explorar el contenido, la forma y la velocidad del pensamiento.

6- SENSOPERCEPCIÓN

Mecanismo Neuropsicológico

- Sensación
- Percepción
- Zona parietal del cerebro
- Áreas asociadas (frontal, parietal, occipital y temporal)

SENSACIÓN: Es nuestra capacidad para detectar sentidos como el tacto, el dolor, la visión o el movimiento, y posicionamiento de nuestro cuerpo.

Es el elemento primario, fundamental y básico de la percepción.

Es el registro en la conciencia de la estimulación producida por cualquiera de los aparatos sensoriales.

La sensación registrada es sometida a elaboraciones psíquicas por las cuales se convierte en una percepción.

PERCEPCIÓN: Es la forma en que el cerebro procesa y comunica estos sentidos al resto del cuerpo. Es una actividad determinada por la atención.

Es un proceso complejo donde intervienen: las sensaciones, evocaciones mnemónicas y asociación de ideas. Su finalidad es la comprensión de lo que se capta.

Una percepción es la conciencia de lo percibido, de las sensaciones y se pueden esperar reacciones emocionales como respuestas a lo percibido.

DEFINICIÓN DE SENSOPERCEPCIÓN

Función psíquica compleja, que permite adquirir todo el material del mundo exterior y del mundo interior físico y mental.

Es un proceso a través del cual capturamos estímulos de nuestro entorno para que puedan ser procesados e interpretados a nivel cerebral.

Es un proceso en el que concurren el procesamiento sensorial y el perceptivo, necesarios ambos para que podamos configurar una realidad coherente y accesible.

ACTIVIDAD SENSORIAL

Para que ello pueda darse se requiere la participación:

Sentidos Externos: implican todos los sentidos, visual, auditivo, táctil, gustativo y olfativo.

Sentidos internos: implican los sentidos de los órganos, cenestésicos, cinético y de orientación.

Cenestesias: Sensación general del estado del propio cuerpo, los órganos sienten mediante receptores específicos que nos hacen percibir cómo están nuestros órganos.

Kinestesia: Se encarga de percibir y controlar el movimiento corporal, así como la posición y el equilibrio. Son receptores que están en las articulaciones haciendo que podamos percibir el sentido horizontal y vertical.

Percepción del mundo mental y nuestra vida Psicológica por la conciencia.

IMÁGENES NORMALES

IMAGEN: Una imagen es una representación mental o visual de algo que puede ser experimentada por la mente. Puede referirse a una representación simbólica o visual de algo real o imaginado. Objeto o situación percibida a través de cualquiera de los sentidos, todo lo que se percibe se caracteriza como imagen.

IMAGEN SENSORIAL: Una imagen sensorial se refiere a una representación mental de la percepción sensorial, como una visualización vívida, un sonido interno, una sensación táctil o cualquier otra experiencia sensorial que se produce en la mente. Imagen percibida a través de los sentidos externos.

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN SENSORIAL

- **Corporeidad:** Propiedad que nace de la observación directa del objetivo de existencia real. Implica que lo que uno está percibiendo existe, cualquiera puede verlo porque tiene cuerpo o forma.
- **Extrayección:** Procede de un objetivo situado fuera de los límites del Yo. Es decir, la imagen viene de afuera.
- **No puede ser modificada por la voluntad:** No es influenciable por la voluntad del individuo. Lo que se percibe es exactamente lo que sucede.
- **Nitidez:** posee claridad y perfecta delimitación.
- **Fijeza:** posee estabilidad.

IMÁGENES NORMALES

IMAGEN CONSECUTIVA: Se refiere a la percepción secuencial de imágenes individuales que dan la percepción de movimiento, como en el cine o en una presentación de diapositivas.

IMAGEN MNEMÓNICA: Es una representación mental que se utiliza para ayudar en la retención o recuperación de la información en la memoria. Son imágenes generadas por la memoria o representadas a través de la memoria.

IMAGEN ONÍRICA: Se refiere a una imagen que aparece en un sueño o pesadilla, asociada con las experiencias oníricas o los contenidos de los sueños. Las pesadillas también son imágenes guardadas en nuestra memoria, que son transformadas por la distorsión de nuestra conciencia generada por el sueño y representadas a nivel cerebral.

PSICOPATOLOGÍA DE LA SENSOPERCEPCIÓN

- ILUSIÓN
- ALUCINACIÓN
- DISMEGALOPSIAS
- ALUCINOSIS

- ALUCINACIONES HIPNAGÓGICAS
- PSEUDOALUCINACIONES
- PERCEPCIÓN DELIRANTE

ILUSIÓN: Distorsión de una imagen real.

Se refiere a una percepción errónea o distorsionada de un estímulo sensorial real, que se interpreta de manera incorrecta por el observador.

Las ilusiones se basan en estímulos reales pero son malinterpretadas.

ALUCINACIÓN: Se refiere a una percepción sensorial que ocurre en ausencia de un estímulo externo apropiado. Esto significa que una persona percibe algo que no está presente en la realidad.

Según Ball: La alucinación es una alteración perceptiva producto de la elaboración de un juicio interferido y desviado, que crea una viva representación originada en una imagen del recuerdo o de la fantasía proyectada al exterior y es aceptada como real como producto de una captación sensorial.

O sea: PERCEPCIÓN SIN OBJETO. Pueden ocurrir en cualquier sentido.

CARACTERÍSTICAS DE LA ALUCINACIÓN

- La imagen no tiene corporeidad (no tiene forma ni cuerpo).
- Sí tiene extrayección, el paciente lo percibe como si viniera de afuera.
- Puede ser modificada por la voluntad del paciente.

TIPOS DE ALUCINACIONES

- SENSORIALES
- CENESTÉSICAS
- CINÉTICAS O KINESTÉSICAS

ALUCINACIONES SENSORIALES

Alucinación Visual: Se observan en estados tóxicos e infecciosos, estados crepusculares, epilepsias. El paciente percibe imágenes que no existen.

Ejemplo: ver a Dios, vírgenes, diablos, animales fantásticos.

Típico de psicosis orgánicas, intoxicación por sustancias.

Alucinación Táctil: El paciente siente toques, pinchazos, quemaduras, movimientos.

Frecuente en esquizofrenia.

Alucinación Auditiva: La más importante clínicamente.

Frecuente en esquizofrenia: voces dialogadas, voces que critican o dan órdenes.

Alucinaciones Olfativas y Gustativas: Dificiles de explorar. Carácter desagradable.

Asociadas a miedo a ser envenenado. En delirios místicos pueden ser placenteras.

Típicas de esquizofrenia paranoide y paranoia.

ALUCINACIONES CENESTÉSICAS: Afectan a los sentidos internos.

Frecuentes en hipocondríacos, neuróticos, melancólicos.

Se quejan de sofocación, disnea, dolores viscerales, palpitaciones.

Melancólicos: manifestaciones graves —creer que los órganos son de piedra o que no existen— llegando incluso a negar la existencia propia (delirio nihilista).

Esquizofrénicos: sensaciones de animales, objetos, cuchillos dentro del cuerpo.

ALUCINACIONES CINÉTICAS O KINESTÉSICAS: Sensación de movimientos inapropiados del cuerpo o partes del cuerpo.

Golpes, empujones, suspensión en el aire.

Frecuentes en delirios tóxicos, infecciosos, delirium tremens y esquizofrenia hebefrénica.

DISMEGALOPSIAS: Distorsiones espaciales de los objetos percibidos.

Alteraciones visuales donde se percibe el tamaño, distancia o forma en modo distorsionado.

Micropsias: objetos más pequeños o más lejanos.

Macropsias: objetos más grandes o más cercanos.

Típico de lesiones de córnea y uso de lentes de contacto.

ALUCINOSIS: Percepciones sin objeto, pero correctamente criticadas por el sujeto.

El paciente reconoce que es anormal.

No genera interpretación delirante.

Típico del alcoholismo, abstinencia, intoxicaciones, infecciones, traumatismos.

ALUCINACIONES HIPNAGÓGICAS: Ocurren antes de dormir o al despertar.

Son visuales, auditivas o táctiles.

Generalmente normales, pero si son persistentes pueden ser patológicas.

Ejemplo: oír el propio nombre antes de dormir.

PSEUDOALUCINACIONES: Imagen formada dentro de la mente, sin extrayección.

El paciente sabe que no es real.

No tiene corporeidad.

Puede modificarse por voluntad.

Luego puede proyectarse al campo perceptivo por carga afectiva.

PERCEPCIÓN DELIRANTE: Interpretación errónea y fija de la realidad.

No se modifica con evidencia en contrario.

Precedida por desviación del juicio, con fuerte influencia afectiva (angustia, recelo).

En esquizofrenia aparece en fase prodrómica.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

Se explora por medio de entrevistas, interrogando y evaluando cada uno de los sentidos con las preguntas correctas.

7. PSICOMOTRICIDAD

¿QUÉ ES LA PSICOMOTRICIDAD?

Es la integración de las funciones motrices y el aparato psíquico del individuo.

Es la interacción de una persona con experiencias cognitivas emocionales y su respuesta a ellas, que involucra todo tipo de movimientos expresivos, como la forma de caminar, gestos faciales o corporales y las posturas en reposo.

Es la función mental que se refiere a todo acto motor voluntario o involuntario.

El estudio de la psicopatología de la motricidad abarca la actividad motora que se refleja en la actitud, gestos, mímica y movimientos tanto aislados como combinados, voluntarios o involuntarios, del ser humano.

CONACIÓN: Acto voluntario e involuntario + la ejecución.

En psicomotricidad, la conación se refiere a la dimensión del comportamiento que está relacionada con la motivación y la voluntad de llevar a cabo una acción.

Es un componente esencial que influye en la manera en que las personas planifican y ejecutan sus movimientos y actividades, y está vinculado a aspectos como la intención, el propósito y la perseverancia en la realización de tareas motrices.

La conciencia ayuda a entender cómo los factores motivacionales y la intención pueden afectar el desarrollo y la coordinación motriz.

MECANISMOS NEUROPSICOLÓGICOS

- ÁREA MOTORA FRONTAL
- ÁREA SENSORIAL PARIETAL
- GANGLIOS BASALES
- CORTEZA CEREBRAL
- MÉDULA ESPINAL
- SINAPSIS NEUROMUSCULAR

PSICOPATOLOGÍA DE LA PSICOMOTRICIDAD

- RETARDO PSICOMOTOR (HIPOBULIA)
- INQUIETUD PSICOMOTRIZ
- AGITACIÓN PSICOMOTRIZ
- ECOPRAXIAS
- ESTEREOTIPIA MOTORA
- MANIERISMOS
- COMPULSIONES

PSICOPATOLOGÍA DE LA PSICOMOTRICIDAD

1) Retardo Psicomotor (Hipobulia): Es una disminución en la velocidad y cantidad de los movimientos físicos. Los pacientes pueden presentar lentitud en sus acciones y respuestas verbales. Ejemplo: Depresión con retardo psicomotor o depresión retardada, uso de sustancias tóxicas como alcohol, sedantes, marihuana.

2) Inquietud Psicomotriz: Es una sensación de incomodidad y agitación o aceleración de la motricidad, que lleva a la persona a moverse constantemente.

Puede presentarse como una incapacidad para permanecer quieto, manifestándose en movimientos repetitivos o nerviosismo.

OJO: Esta aceleración de la motricidad siempre tiene un objetivo determinado, está dirigida hacia una acción.

Ejemplo: Ansiedad intensa, hipomanía, uso de estimulantes, cafeína, cocaína, éxtasis.

3) Agitación Psicomotriz: Se caracteriza por una actividad motora excesiva, a menudo acompañada de un estado emocional alterado.

Los pacientes pueden estar inquietos, moverse rápidamente y de manera no coordinada, y mostrar comportamiento impulsivo.

OJO: Esta aceleración ocurre sin ningún motivo aparente, no posee un fin determinado ni una acción específica.

Ejemplo: Manía, brotes psicóticos agudos, intoxicación por drogas (cocaína, anfetamina).

4) Ecopraxias: Imitación involuntaria de los movimientos de otra persona o de acciones observadas.

El paciente repite un acto motor realizado por el entrevistador, pero en espejo.

Ejemplo: Esquizofrenia residual y hebefrénica.

5) Estereotipia Motora: Movimientos repetitivos, rítmicos y sin propósito.

Persistentes y pueden interferir con actividades diarias.

Se repite un acto motor sin relación con la actividad que se está realizando.

Ejemplo: Psicosis, autismo.

6) Manierismos: Movimientos o gestos exagerados, inusuales, repetitivos y característicos del comportamiento.

Incluye formas peculiares de mover manos o caminar.

Ejemplo: Psicosis residual y hebefrénica.

7) Compulsiones: Conductas repetitivas y ritualizadas que la persona siente necesidad de realizar en respuesta a una obsesión o regla rígida.

Actos motores destinados a reducir malestar o evitar un evento temido.

Ejemplo: TOC.

8) Trastornos Catatónicos: Síndromes catatónicos o esquizofrenia catatónica:

- Flexibilidad cérea
- Posturas forzadas
- Obediencia automática
- Negativismo
- Cataplexia

Trastornos Catatónicos

- a. **Flexibilidad cérea:** Extremidades que pueden ser movidas por otra persona y permanecen en la posición dejada, como si fueran de cera. Tonicidad muscular similar a la cera.
- b. **Posturas forzadas:** Posiciones anormales y sostenidas, adoptadas espontáneamente o inducidas, mantenidas por largos periodos.
- c. **Obediencia automática:** Tendencia a seguir órdenes sin cuestionar, incluso si son absurdas o peligrosas.

- d. **Negativismo:** Resistencia activa o pasiva frente a instrucciones o intentos de movilidad. Oposición a todo lo que se le pide.
- e. **Cataplexia:** Pérdida repentina del tono muscular, desencadenada por emociones fuertes.

Puede caer al suelo, pero conserva conciencia.

El paciente puede quedar sin tono muscular por horas, días, semanas o meses.

Ejemplo: Esquizofrenia catatónica, trastornos orgánicos como encefalitis.

PSICOPATOLOGÍA DE LA PSICOMOTRICIDAD

- TEMBLOR
- DISTONÍA
- TICS
- CONTRACTURA
- MIOCLONÍAS
- FIBRILACIÓN
- FASCICULACIÓN

Temblor: Movimientos oscilatorios, involuntarios y rítmicos de grupos musculares.

Afectan manos, cabeza, rostro, cuerdas vocales, tronco o piernas.

Tipos:

. Temblor esencial o familiar:

. Temblor fino de los dedos; genético; puede aparecer por sustancias, estimulantes, ansiedad, fatiga, hipomanía.

. Temblor de Parkinson: “Cuenta monedas”.

. Visible en reposo; disminuye con actividad.

Distonía: Contracciones musculares sostenidas que provocan movimientos repetitivos o posturas anormales. Puede ser primaria o secundaria.

Ejemplo:

Trastornos histriónicos tipo “posesión demoníaca” (arco).

Uso prolongado de antipsicóticos → distonías cervicales.

También aparece en calambres y tortícolis.

Tics: Movimientos o vocalizaciones rápidas, repetitivas y no rítmicas.

Frecuentes en síndrome de Tourette.

Relacionados con estrés, ansiedad y trastornos neuropsiquiátricos.

Contractura: Rigidez o acortamiento muscular con limitación articular.

Contracción brusca de grupos musculares (ej: cuello).

Causas: lesiones, inmovilización, ansiedad, sustancias tóxicas.

Mioclonías: Sacudidas breves, rápidas e involuntarias de uno o varios músculos.

Pueden ser fisiológicas (hipo), epilépticas o metabólicas.

Ejemplo: cansancio, estrés intenso, abuso de sustancias.

Fibrilación: Contracciones espontáneas de fibras musculares individuales, no visibles a simple vista.

Asociadas a lesiones nerviosas o alteraciones cardíacas.

Fasciculación: Contracciones involuntarias de unidades motoras completas, visibles bajo la piel.

Benignas (fatiga, cafeína) o asociadas a (E,L,A, . Esclerosis Lateral Amiotrófica) .

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

La exploración psicopatológica evalúa características motoras y conductuales observando alteraciones en movimiento, postura y tono muscular.

El entrevistador interviene:

ACTIVA: Dando órdenes para realizar movimientos.

PASIVA: Observando movimientos voluntarios e involuntarios.

8. NEUROSIS

CONCEPTO DE NEUROSIS

- La Neurosis o Neuroticismo, también conocida como inestabilidad emocional es un rasgo psicológico que define parte de la personalidad, de las características psíquicas de una persona.

- Es un trastorno que tiene una evolución crónica o recurrente, que no produce una pérdida de contacto con la realidad como las psicosis y que se manifiesta principalmente por la presencia de Angustia o Ansiedad.
- Se trata de un rasgo característico que puede acompañar al sujeto durante toda su vida, de gravedad muy variable, desde grados leves y controlables, hasta situaciones gravemente incapacitantes que pueden llegar a precisar hospitalización.
- Se presupone que los factores ambientales tienen un papel predominante en este tipo de enfermedad.

CARACTERÍSTICAS

- Tristeza continua, sufrimiento emocional frecuente.
- Falta de interés por hacer cosas que diviertan o reporten placer.
- Intolerancia a los demás y tendencia a la timidez.
- Irritabilidad y “explosiones” en las conversaciones con otras personas.
- Sudoración excesiva de las manos.
- Ansiedad y Preocupación excesiva.
- Problemas de relación interpersonal.
- Excesivas preocupaciones sin causa aparente.
- Desarrollo de conductas rituales o repetitivas tipo trastorno obsesivo-compulsivo.
- Orden excesivo.
- Descanso irregular o insomnio.
- Dolor de cabeza, Voluntad débil.
- Pérdida de las ganas de trabajar o dificultad para ir a trabajar o salir de casa.
- Incapacidad para tomar decisiones adecuadas.
- Sentimientos de angustia y culpa.

CLASIFICACIÓN

- **Neurosis de angustia:** Es episódica y suele presentar mareos, vómitos, diarrea, taquicardia, ahogos, zumbido, sudoración, pesimismo, sensación de amenaza, hormigueo de alguna parte del cuerpo y adormecimiento.
- **Neurosis fóbica:** Miedos intensos irracionales hacia objetos o situaciones. Puede llevar a ataques de angustia y fobias irracionales.
- **Neurosis obsesiva-compulsiva:** Lucha constante contra pensamientos, imágenes y palabras que aparecen en contra de la voluntad. Pensamientos persistentes de contenido angustioso e incontrolables. Hay depresión y sentimiento de culpa.
- **Neurosis hipocondríaca (Hipocondriasis):** Preocupaciones por las funciones orgánicas y el padecimiento de enfermedades.
- **Neurasténica:** Debilidad, fatigabilidad y baja autoestima.
- **Neurosis depresiva:** Depresión o tristeza exagerada, pérdida de autoestima, autocrítica excesiva y baja autoconfianza.
- **Neurosis histérica (Histeria):** Conversiva o Disociativa.

• **Neurosis de Desrealización:** Se refiere a la sensación de que el entorno externo no es real. Las personas que experimentan desrealización pueden sentir que el mundo que las rodea es irreal, borroso, distante o artificial. Los objetos pueden parecerles extraños o distorsionados, y es posible que sientan que el tiempo pasa de manera anormal.

• **Neurosis de despersonalización:** Sentimientos de irrealidad hacia sí mismo y el entorno. Es la experiencia de sentirse desconectado o separado de uno mismo. Las personas que experimentan despersonalización pueden sentir que están observando su cuerpo desde afuera o que no tienen control sobre sus propias acciones y pensamientos. Pueden describir la sensación como si estuvieran en un sueño o en una película.

HIPOCONDRIASIS

- Convencimiento persistente de tener una o más enfermedades graves.
- Preocupación persistente por una presumible deformidad o desfiguración.
- La preocupación y ansiedad persistente a padecer los síntomas de la enfermedad y/o deformidad, causa malestar o invalidez social que lleva al paciente a realizar reiteradas consultas y pruebas médicas.
- Esta preocupación puede persistir incluso después de pruebas médicas exhaustivas que no muestran ninguna enfermedad.
- Rechazo a aceptar que las molestias carecen de causa orgánica.

HISTERIA

• **CONVERSIVAS:** Actualmente conocida como trastorno de conversión, es un diagnóstico que se refiere a la presencia de síntomas neurológicos que no tienen una base médica o neurológica clara y que se cree que son el resultado de conflictos psicológicos.

• Se representan como una enfermedad física o como el concepto que el paciente tiene de una enfermedad física, no habiendo ninguna evidencia de daño orgánico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✓ Síntomas físicos: Parálisis, pérdida de sensibilidad, temblores, convulsiones, problemas de coordinación, ceguera o sordera. Síntomas reales para la persona, sin explicación neurológica.

✓ Falta de base médica: Estudios sin causa física.

✓ Conexión psicológica: Síntomas relacionados al estrés o conflicto interno.

✓ Impacto en la vida diaria: Afecta trabajo, actividades sociales, etc.

HISTERIA - SÍNTOMAS

- Afonía, mutismo.
- Convulsiones, pseudoconvulsiones.
- Anestesia y pérdida sensorial.
- Parálisis de diversas partes del cuerpo, temblores.
- Pérdida de conciencia, desmayos.

- Pérdida de la visión.

HISTERIA DISOCIATIVA

- Suele estar asociada con experiencias traumáticas severas, especialmente en la infancia.
- Considerada una forma de lidiar con el trauma y el estrés extremo.
- Implica pérdida parcial o total de recuerdos, identidad o sensaciones inmediatas, por estrechamiento de la conciencia.

HISTERIA DISOCIATIVA – TIPOS

1) AMNESIA DISOCIATIVA

- Incapacidad de recordar información personal importante, generalmente traumática, no explicable por olvido ordinario.
- Está asociada a mecanismos disociativos como defensa ante trauma.

2) FUGA DISOCIATIVA

- Huida o desplazamiento inesperado lejos del hogar.
- Pérdida de identidad y amnesia del pasado.
- Puede adoptar una nueva identidad.

3) PERSONALIDAD MÚLTIPLE (Trastorno de Identidad Disociativo - TID)

Características:

- Identidades distintas que alternan en control.
- Cada identidad posee su estilo, percepción y comportamiento.
- Amnesia disociativa entre identidades.
- Cambios súbitos e impredecibles.
- Despersonalización y desrealización.
- Relación estrecha con trauma infantil.

4) TRANCE Y POSESIÓN: Alteración temporal del estado de conciencia e identidad, percibiendo control externo.

Características del Trance:

- Estado alterado de conciencia.
- Focalización intensa o absorción.
- Amnesia parcial o completa.

Características de la Posesión:

- Cambio de identidad bajo creencia de control externo.
- Pérdida de control sobre acciones, habla y pensamientos.
- Manifestaciones físicas: Cambios de voz, postura, fuerza, conductas inusuales.

- Influencia cultural relevante.

DIFERENCIAS ENTRE TID Y TRANCE/POSESIÓN

- El TID implica identidades múltiples internas; el trance/posesión implica control externo percibido.
- El TID es crónico y relacionado con trauma; el trance/posesión puede ser temporal y culturalmente condicionado.

9- TRASTORNOS AFECTIVOS

TRASTORNOS AFECTIVOS: Conjunto de trastornos psicopatológicos que básicamente tienen como alteración principal, la tristeza patológica y/o la alegría patológica, acompañado de otros trastornos o síntomas derivados de ellos o asociados a ellos. Se clasifican en: Depresión Unipolar y sus distintos tipos. Depresión Bipolar y sus distintos tipos. Ciclotimia

DEPRESIÓN UNIPOLAR - CLASIFICACIÓN:

a- DEPRESIÓN ENDÓGENA: (Trastorno Depresivo Mayor, Depresión Biológica, Depresión Genética o Familiar)

b- DEPRESIÓN PSICÓGENA: (Trastorno Depresivo Menor, Depresión Adaptativa, Depresión por Estrés, Depresión por Agotamiento, Depresión Vivencial, Psicológica o Reactiva)

c- DEPRESIÓN SOMATÓGENA: (Depresión por Enfermedad Médica; Depresión por Causas Físicas, Depresión Orgánica)

d- DISTIMIAS.

DEPRESIÓN: SINTOMAS BASICOS

- Tristeza patológica.
- Ansiedad patológica.
- Disminución de la atención y concentración.
- Disminución de la memoria, sobre todo la de fijación.
- Retardo o inquietud psicomotriz.
- Pensamiento lento.
- Ideas de minusvalía, desesperanza, culpa, ruina.
- Lenguaje lento, monosilábico.
- Delirios de ruina, culpa y pobreza si la depresión es psicótica.
- Sensopercepción y Juicio conservados, Excepto en la depresión psicótica.
- Disminución o aumento de apetito y peso
- Insomnio o hipersomnia.
- Trastornos sexuales (anorgasmia, frigidez, impotencia, hipofunción libidinal)
- Alteraciones gastrointestinales (estreñimiento, dispepsias, meteorismo)
- Aislamiento
- Ensimismamiento
- Ideas obsesivas (contaminación, control)
- Ideas suicidas

- Ideas hipocondriacas
- Cefaleas (dolores de cabeza frontales y nucales)
- Miedo intenso a la soledad
- Irritabilidad
- Trastorno del ciclo circadiano

DEPRESIÓN ENDÓGENA: Es un tipo de depresión que se considera originada por factores biológicos o genéticos internos, en contraste con factores ambientales o psicológicos externos. Suele tener un comienzo más temprano en la vida y a menudo se asocia con una alteración en los neurotransmisores cerebrales. Las personas con depresión endógena pueden experimentar síntomas graves incluso sin factores estresantes evidentes en su entorno.

LOS SÍNTOMAS QUE CARACTERIZAN A LA ENFERMEDAD SON:

1. Inicio en adultos jóvenes (adolescentes o adultez temprana) con o sin precipitantes.
2. Se cree que tiene una base biológica o genética, relacionada con desequilibrios en neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina.
3. Retardo o agitación psicomotriz.
4. Disminución de apetito y de peso.
5. Insomnio tardío (el paciente empieza a dormir bien, se despierta y ya no puede volver a dormir).
6. Se sienten peor a la mañana y mejor a la tarde (les cuesta mucho empezar el día).
7. Presentan más suicidios consumados y menos intentos de suicidios.
8. Casi siempre tienen antecedentes familiares de depresión.
9. El tratamiento es más farmacológico que psicoterapéutico.
10. Son depresiones crónicas, recurrentes, que se presentan durante toda la vida, pueden mejorar 6 meses o un año, para posteriormente volver a presentar los síntomas característicos de la depresión aún con medicación.
11. **Melancolía Involutiva:** Es una forma de depresión endógena que avanza con mucha ansiedad y suele dar agitación psicomotriz. Lleva habitualmente a la muerte del paciente por agitación o suicidio.

DEPRESIÓN PSICÓGENA: Se refiere a la depresión que se desarrolla como respuesta a factores psicológicos o emocionales externos, como el estrés, traumas o conflictos interpersonales o intrapsíquicos. En este caso, los desencadenantes suelen estar relacionados con experiencias vitales adversas o situaciones estresantes que afectan el estado emocional y mental de la persona.

LOS SÍNTOMAS QUE CARACTERIZAN A LA ENFERMEDAD SON:

1. Inicio a cualquier edad. Habitualmente con precipitantes (estrés, adaptativo, conflictos intrapsíquicos).
2. Inquietud psicomotriz.
3. Aumento de apetito y peso, más raro que se presente disminución.
4. Insomnio Inicial (el paciente no puede empezar a dormir, pero una vez que lo hace, ya duerme toda la noche).
5. Se sienten mejor a la mañana y peor a la tarde.
6. Presentan mas intentos de suicidio, que suicidios consumados
7. Puede o no haber antecedentes familiares (la mayor parte de estos pacientes no presentan antecedentes).

8. El tratamiento se centra principalmente en psicoterapia con menor cantidad de medicación.

DEPRESIÓN SOMATÓGENA: Es la asociación de síntomas psicopatológicos endógenos y psicógenos. Es un tipo de depresión que resulta de una afección médica subyacente o de un desequilibrio físico en el cuerpo. Este tipo de depresión puede ser causado por trastornos neurológicos, enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, Traumatismos craneoencefálicos, Hiperkortisolemia, efectos secundarios de ciertos medicamentos o la utilización de fármacos depresores.

DISTIMIA: La distimia, actualmente conocida como Trastorno Depresivo Persistente (TDP), es un tipo de depresión crónica y de bajo grado (menos severa) que persiste durante al menos dos años. Puede comenzar en la infancia, adolescencia o adultez. Los síntomas suelen ser menos graves que en la depresión mayor, pero son constantes y pueden afectar la capacidad de la persona para funcionar normalmente. La distimia implica un estado de ánimo deprimido que dura la mayor parte del tiempo durante el periodo especificado.

TRASTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE (DISTIMIA): Los síntomas más comunes de la Distimia, son menos severos pero más crónicos que los síntomas de la depresión mayor.

- Tristeza patológica
- Sensación de vacío persistente.
- Llanto fácil excesivo
- Disminución de energía
- Aislamiento social
- Sentimientos de desesperanza.

Se lo conoce como depresión incrustada en la personalidad

Diagnóstico: Estado de ánimo deprimido durante al menos dos años

Prevalencia: Es un trastorno común entre la población general, afecta de un 3 % a un 5 %

Tratamiento: Farmacológico. Psicoterapia

TRASTORNO BIPOLAR - CLASIFICACIÓN

- Trastorno BIPOLAR I
- Trastorno BIPOLAR II
- Trastorno BIPOLAR MIXTO
- Trastorno BIPOLAR CICLADOR RÁPIDO
- CICLOTIMIA

- a. **TRASTORNO BIPOLAR I:** Es un trastorno mental caracterizado por la presencia de al menos un episodio maníaco que puede estar precedido o seguido de episodios depresivos mayores. Un episodio maníaco se define por un estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable, que dura al menos una semana y está asociado con un aumento de la actividad dirigida a metas, energía excesiva, y, a menudo, un deterioro significativo en el funcionamiento social u ocupacional.

Manía + Depresión + Periodo libre de síntomas

Es una enfermedad psiquiátrica crónica (a largo plazo) y debilitante que se caracteriza por episodios repetidos de manía y depresión o una mezcla de ambos.

FASE MANÍACA

- Estado excesivamente alegre o sobreexcitado
- Euforia contaminante
- Aumento de energía y la actividad
- Autoestima excesiva
- Fuga de ideas, verborrea
- Hablar excesivamente
- Tendencia a una conducta impulsiva
- Delirios megalomaniacos
- Implicación excesiva en actividades placenteras con alto potencial de consecuencias negativas (ej. compras compulsivas, conductas sexuales de riesgo).
- Aumento de la actividad orientada a metas o agitación psicomotora.

FASE DEPRESIVA

- Disminución de la energía y la actividad
- Tristeza patológica
- Llanto
- Sentimientos de culpa
- Dificultad de concentración
- Pérdida del apetito
- Pensamientos de muerte o suicidio
- Distractibilidad
- Disminución de la necesidad de dormir.

b. TRASTORNO BIPOLAR II: Se caracteriza por la ocurrencia de al menos un episodio hipomaniaco y uno o más episodios depresivos mayores. A diferencia del Trastorno Bipolar I, los episodios hipomaniacos son menos intensos que los maníacos y no causan un deterioro significativo en la vida social u ocupacional, ni requieren hospitalización.

Hipomanía + Depresión + Periodo libre de síntomas

Es un patrón del estado de ánimo que se caracteriza por episodios depresivos mayores alternados con episodios hipomaniacos.

FASE HIPOMANIACA

- Los episodios hipomaniacos son similares a los síntomas de la manía, pero menos graves y duraderos (mínimo 4 días).
- Estado demasiado elevado.
- Aumento visible y persistente de energía.
- Autoestima excesiva y sentimientos de grandeza.
- Inquietud psicomotora.

FASE DEPRESIVA

- Disminución de la energía y la actividad

- Tristeza patológica
 - Llanto fácil
 - Sentimientos de culpa
 - Anhedonia
 - Dificultad de concentración
 - Pérdida del apetito
 - Pensamientos de muerte o suicidio, mayor riesgo.
 - Alteraciones del sueño.
 - Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva
- c. **TRASTORNO BIPOLAR MIXTO** En este subtipo de trastorno bipolar, los episodios presentan características mixtas, es decir, síntomas tanto maníacos como depresivos ocurren al mismo tiempo o en rápida sucesión. Esto puede resultar en estados de ánimo extremadamente fluctuantes dentro de un mismo día o durante el mismo episodio.

SÍNTOMAS

Coexistencia de síntomas maníacos e hipomaníacos (elevación del ánimo, irritabilidad, etc.) junto con síntomas depresivos (tristeza, desesperanza, etc.).

Puede incluir agitación, insomnio, irritabilidad extrema, y pensamientos acelerados acompañados de una profunda tristeza o desesperanza.

Este tipo de presentación aumenta el riesgo de suicidio y de hospitalización debido a la inestabilidad del estado de ánimo.

- d. **TRASTORNO BIPOLAR CICLADOR RÁPIDO:** Se define por la presencia de cuatro o más episodios de alteración del estado de ánimo (maníacos, hipomaníacos, depresivos o mixtos) en un período de 12 meses. Es más común en mujeres que en hombres y puede complicar el tratamiento y el pronóstico del trastorno.

SÍNTOMAS

- Rápida alternancia entre episodios de manía, hipomanía, depresión, o estados mixtos.
 - Frecuentemente asociado con una menor respuesta al tratamiento.
 - Estos ciclos rápidos pueden ser desencadenados o exacerbados por el uso de antidepresivos, y están asociados a un curso más crónico y un pronóstico menos favorable.
- e. **CICLOTIMIA:** Es una forma más leve de trastorno bipolar, caracterizada por la fluctuación crónica del estado de ánimo con períodos de síntomas hipomaníacos y depresivos que no cumplen con los criterios completos para un episodio maníaco, hipomaníaco o depresivo mayor. Los síntomas persisten durante al menos dos años (uno en niños y adolescentes).
- Inicio en adultos jóvenes.
 - Cambio brusco del estado de ánimo entre la alegría y la tristeza.
 - El humor puede cambiar en el transcurso de días y muchas veces en horas y ante el menor estímulo.
 - Períodos de síntomas hipomaníacos que no cumplen con los criterios completos para un episodio hipomaníaco.
 - Períodos de síntomas depresivos que no cumplen con los criterios para un episodio depresivo mayor.

- Evolución crónica.

10 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

DEFINICIÓN PSICOPATOLÓGICA DE PERSONALIDAD

- ✓ La personalidad se refiere a un conjunto único de patrones de pensamiento, emociones y comportamientos que caracterizan a un individuo y afectan su forma de relacionarse con el mundo y con los demás.
- ✓ Desde una perspectiva psicopatológica, los trastornos de la personalidad son patrones permanentes de comportamiento y experiencia interna que se desvían notablemente de las expectativas culturales, son inflexibles y se manifiestan en múltiples contextos.
- ✓ Estos patrones suelen provocar deterioro en la función social, laboral y personal y se caracterizan por dificultades en el control emocional, en las relaciones interpersonales y en la autopercepción.

PERSONALIDAD NORMAL Y ANORMAL

- Personalidad Normal: Características y patrones de comportamiento típicos y funcionales en el contexto cultural.
- Permite adaptarse a diversas situaciones sociales, regular emociones y mantener relaciones saludables.
- Personalidad Anormal: Patrones desadaptativos que se desvían significativamente de las normas culturales.
- Incluye comportamientos extremados, inflexibles o inadaptados que generan problemas en la vida personal o en las relaciones con los demás.

Los trastornos de la personalidad son un tipo de personalidad anormal.

ESTADO Y RASGO DE PERSONALIDAD

- Estado de personalidad: Reacciones emocionales y comportamentales temporales, cambiantes según experiencias o contexto.
- Ejemplo: Sentirse ansioso o irritable en un momento dado, pero cambiar en otra situación.
- Rasgo de personalidad: Características estables y duraderas que distinguen a una persona.
- Patrones consistentes de conducta, pensamiento y emocionalidad.
- Ejemplo: extrovertido vs. introvertido.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD

- Patrones inflexibles.
- Percepción distorsionada de sí mismos y de los demás.
- Deterioro funcional significativo social, laboral y personal.
- Inicio en adolescencia o adultez temprana.
- Resistencia al cambio.
- Impacto emocional, reacciones extremas o inapropiadas.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD

Según DSM-5, se agrupan en tres clases:

1. Clase A: Trastornos Raros o Excéntricos

- ✓ Trastorno Paranoide
- ✓ Trastorno Esquizoide
- ✓ Trastorno Esquizotípico

2. Clase B: Trastornos Dramáticos, Emocionales o Erráticos

- ✓ Trastorno Antisocial
- ✓ Trastorno Límite
- ✓ Trastorno Histriónico
- ✓ Trastorno Narcisista

3. Clase C: Trastornos Ansiosos o Temerosos

- ✓ Trastorno Evitativo
- ✓ Trastorno Dependiente
- ✓ Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la Personalidad

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD DEL GRUPO A

1- TRASTORNO PARANOIDE

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS

a) Patrón de desconfianza y suspicacia general hacia otros, incluyendo amigos, familia y pareja. Las intenciones ajenas se interpretan como maliciosas.

- b) Creencia de que otros se van a aprovechar, dañar o engañar, sin pruebas reales.
- c) Inicio al principio de la edad adulta, presente en diversos contextos.
- d) Extremadamente sensibles a reveses, sienten vergüenza y humillación con facilidad.
- e) Tendencia al aislamiento y destrucción de relaciones cercanas.
- f) Albergan rencores, no olvidan insultos o injurias; mínima crítica provoca gran hostilidad prolongada.
- g) Celos patológicos: sospechan infidelidad sin justificación.
- h) Preocupación por lealtad de amigos; examinan acciones buscando intención hostil.
- i) Reacios a confiar o intimar por temor a que la información sea usada en su contra.
- j) Interpretan significados ocultos degradantes en hechos inocentes.
 - Ejemplo: error en el cambio interpretado como intento deliberado.
- k) Malinterpretan halagos como críticas encubiertas o manipulaciones.

2- TRASTORNO ESQUIZOIDE

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS

- a) Se aíslan y evitan actividades sociales y relaciones interpersonales.
- b) Organizan su vida evitando contacto; no desean ni disfrutan relaciones cercanas. Prefieren trabajos y actividades solitarias, muestran frialdad emocional.
- c) Prefieren estar solos, centrarse en sí mismos.
- d) Inicio en adultez temprana.
- e) Indiferentes a aprobación o crítica.
- f) Dificultad para expresar ira incluso ante provocación → apariencia de ausencia emocional.
- g) Deterioro laboral si requiere contacto interpersonal; funcionan bien en aislamiento.
- h) Episodios psicóticos breves ante estrés (minutos u horas).

3- TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS

- a) Rarezas en apariencia, comportamiento y habla; experiencias perceptivas inusuales y anomalías del pensamiento similares a esquizofrenia.
- b) Afecto inapropiado, ansiedad social, frialdad interpersonal, aislamiento.

- c) Pensamiento mágico, supersticiones, creencias en poderes especiales, experiencias paranormales.
- d) Ideas de referencia (interpretaciones incorrectas de hechos casuales como significativos).
- e) Creencias de tener poderes especiales (leer mente, anticipar hechos).
- f) Creencia en control mágico sobre otros, directo o mediante rituales.
- g) Alteraciones perceptivas (sentir presencia, oír nombre murmurado).
- h) Ideación paranoide (creer que colegas quieren perjudicar reputación).
- i) Percibidos como raros o excéntricos; manera de vestir inusual, falta de habilidades sociales.
- j) Suelen buscar tratamiento por ansiedad, depresión o disforia.
- k) Más de la mitad presentan antecedentes de un episodio depresivo mayor.

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD DEL GRUPO B

1- TRASTORNO ANTISOCIAL: La característica esencial es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta.

Este patrón también ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad.

➤ Para que se pueda establecer este diagnóstico el sujeto debe tener al menos 18 años y tener historia de algunos síntomas de un trastorno disocial antes de los 15 años.

➤ Los comportamientos característicos específicos del trastorno disocial forman parte de una de estas cuatro categorías:

- Agresión a la gente o los animales
- Destrucción de la propiedad
- Fraudes o hurtos
- Violación grave de las normas.

➤ El patrón de comportamiento antisocial persiste hasta la edad adulta.

No logran adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal.

Pueden perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención (que puede o no producirse) como la destrucción de una propiedad, hostigar o robar a otros, o dedicarse a actividades ilegales.

➤ Las probabilidades de desarrollar un trastorno antisocial de la personalidad en la vida adulta aumentan si el sujeto presenta un trastorno temprano disocial (antes de los 10 años) y un trastorno por déficit de atención con hiperactividad asociado.

➤ El maltrato o el abandono en la infancia, el comportamiento inestable o variable de los padres o la inconsistencia en la disciplina por parte de los padres aumentan las probabilidades de que un trastorno disocial evolucione hasta un trastorno antisocial de la personalidad.

➤ Los individuos con trastorno antisocial de la personalidad tienen pocos remordimientos por las consecuencias de sus actos.

Pueden ser indiferentes o dar justificaciones superficiales por haber ofendido, maltratado o robado a alguien, por ejemplo:

“La vida es dura”, “el que es perdedor es porque lo merece”, “de todas formas le hubiese ocurrido”.

➤ Pueden involucrarse en comportamientos sexuales o consumo de sustancias con alto riesgo de consecuencias perjudiciales.

Pueden descuidar o abandonar el cuidado de un niño, poniendo en peligro su integridad.

2- TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

La característica esencial es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos.

➤ Realizan frenéticos esfuerzos para evitar un abandono real o imaginado.

➤ La percepción de una separación o rechazo inminente, o pérdida de estructura externa, ocasiona cambios profundos en la autoimagen, afectividad, cognición y comportamiento.

➤ Son muy sensibles a las circunstancias ambientales.

➤ Muestran impulsividad en al menos dos áreas potencialmente peligrosas:

- Apuestas
- Gastos irresponsables
- Atracones
- Abuso de sustancias
- Prácticas sexuales no seguras
- Conducción temeraria.

➤ Presentan comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes y automutilación.

➤ El suicidio consumado se observa en un 8–10% de estos sujetos.

Actos de automutilación y amenazas o intentos de suicidio son muy frecuentes.

➤ El estado de ánimo básico disfórico suele interrumpirse por períodos de ira, angustia o desesperación; rara vez un estado de bienestar ocupa su lugar.

➤ Pueden mostrar sarcasmo extremo, amargura persistente o explosiones verbales.

- Son frecuentes las pérdidas repetidas de trabajo, interrupciones de estudios y rupturas matrimoniales.

3- TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD

TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD

La característica esencial es la emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda de atención.

Este patrón empieza al principio de la edad adulta.

- No están cómodos o se sienten despreciados cuando no son el centro de atención.
- Son vivaces, dramáticos, seductores; al principio agradan por su entusiasmo y apertura.
- Sus relaciones con amigos del mismo sexo están deterioradas por su estilo interpersonal sexualmente provocativo.
- Buscan novedad, estimulación y excitación; se aburren con la rutina.
- Forma de hablar excesivamente subjetiva, carente de matices; opiniones contundentes pero argumentos vagos.
- Hacen el papel de “alma de la fiesta”; si no son el centro de atención, inventan historias o hacen drama.
- Consideran las relaciones más íntimas de lo que son; llaman “mi querido amigo” a casi cualquier conocido y tutean médicos tras verlos una o dos veces.
- Frecuentes fantasías románticas; son altamente sugestionables.

4- TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD

TRASTORNO DE PERSONALIDAD NARCISISTA

La característica esencial es un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que empieza en comienzo de la edad adulta y se da en diversos contextos.

- Creen ser superiores, especiales o únicos, y esperan ser reconocidos como tales. Tienen sentido grandioso de autoimportancia.
- Sobrevaloran sus capacidades y exageran conocimientos; parecen jactanciosos y presuntuosos.
- Autoestima frágil; preocupación por desempeño y percepción ajena.
- Esperan ser recibidos con fanfarrias (bombos y platillos por ejemplo); se sorprenden si no son envidiados. Necesidad constante de atención y admiración.
- Envidian a los demás o creen que los demás los envidian. Consideran que merecen privilegios o logros ajenos.

- Son rencorosos, mantienen resentimiento y venganza.
- Asociado a anorexia nerviosa y trastornos por sustancias (especialmente cocaína).

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD DEL GRUPO C

1- TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR EVITACIÓN

Patrón general de inhibición social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación negativa.

- Experimentan sentimientos de inferioridad.
- Viven pendientes de críticas; evitan nuevas actividades o amistades por sentirse ineptos o poco atractivos.
- Miedo constante a ser avergonzados o rechazados.
- Fuertemente asociado a trastornos de ansiedad; puede originarse en rechazo temprano.
- Son capaces de relaciones íntimas solo cuando hay seguridad de aceptación.
- Tímidos, callados, inhibidos e invisibles para evitar humillación o rechazo.
- Problemas en actividad social y laboral.
- Frecuentemente coexiste con trastorno de personalidad dependiente, volviéndose muy dependientes de amigos aceptados.

2-TRASTORNO DE PERSONALIDAD DEPENDIENTE

Característica esencial: Necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, causando conducta de sumisión, adhesión y temores de separación.

- Conductas sumisas destinadas a provocar atención; percepción de incapacidad para funcionar sin ayuda.
- Gran dificultad para decisiones cotidianas sin excesiva consejería.
- Evitan estar solos; pueden tolerar abuso físico o verbal.
- Adultos dependen de padres o cónyuge para decidir domicilio, amistades, trabajo.
- Adolescentes permiten que padres decidan ropa, amistades, escuela, actividades.
- Puede coexistir con enfermedades médicas graves, pero la dificultad debe exceder lo esperable.
- Se ven a sí mismos como ineptos; pueden funcionar adecuadamente si alguien supervisa y aprueba.

3- TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO DE LA PERSONALIDAD

Personas muy disciplinadas, con imperiosa necesidad de orden y fuerte adhesión a normas y reglamentos.

- Rígidas, perfeccionistas, rumiadoras, moralistas, inflexibles e indecisas.
- Muy incómodas cuando no logran perfección.
- Excesivamente cuidadosas; repiten tareas, revisan errores, atención extraordinaria a detalles.
- Intentan mantener control mediante listas, reglas, detalles triviales hasta perder de vista el objetivo principal.
- El perfeccionismo provoca disfunción y malestar significativo.
- Dedicación excesiva al trabajo y productividad, excluyendo ocio y amistades; no motivado por necesidades económicas.
- Creen no tener tiempo para relajarse; posponen actividades placenteras indefinidamente.
- Pueden ser tacaños y avaros; viven por debajo de sus posibilidades por miedo a catástrofes futuras.
- Expresión afectiva muy controlada; incomodidad ante personas expresivas emocionalmente.
- Dan instrucciones detalladas sobre cómo debe hacerse todo; irritación si otros sugieren alternativas.

CLASIFICACIÓN

Los trastornos se agrupan en tres Clases por características comunes:

Grupo	Estilo dominante	Trastornos
A	Raros – Excéntricos	Paranoide, Esquizoide, Esquizotípico
B	Dramáticos – Impulsivos	Histriónico, Narcisista, Límite, Antisocial
C	Ansiosos – Temerosos	Evitativo, Dependiente, Obsesivo-compulsivo

GRUPO A – “Raros o Excéntricos”

Trastorno	Núcleo clínico	Rasgos típicos	Diferenciar de...
Paranoide	Desconfianza constante	Celotipia, interpretaciones maliciosas	Delirio paranoide (Psicosis: pierde realidad)

Esquizoide	Aislamiento voluntario	Frialdad emocional, sin deseo afectivo	Autismo (Inicio temprano)
Esquizotípico	Conducta extraña, ideas raras	Creencias mágicas, afecto inapropiado	Esquizofrenia (Síntomas Francos +)

Pocas relaciones sociales

Pobre expresividad afectiva

GRUPO B – “Dramáticos, Emocionales, Impulsivos”

Trastorno	Núcleo clínico	Rasgos característicos	Riesgos
Histriónico	Búsqueda de atención	Seducción, teatralidad, emocionalidad superficial	Relación dependencia/abuso
Narcisista	Grandiosidad + necesidad de admiración	Envidia, falta de empatía	Depresión ante crítica
Antisocial	Violación de Normas y Derechos	Impulsividad, engaño, agresión	Criminalidad, drogas
Límite (Borderline)	Inestabilidad afectiva y vínculos	Autolesiones, vacío, miedo al abandono	Suicidio, abuso de sustancias

Grupo con mayor demanda Clínica y Riesgo de Crisis Impulsivas

GRUPO C – “Ansiosos o Temerosos”

Trastorno	Núcleo clínico	Conductas visibles	Tratamiento útil
Evitativo	Hipersensibilidad a crítica	Evita contacto, deseo de aceptación	TCC + entrenamiento social
Dependiente	Necesidad extrema de apoyo	Sumisión, miedo a la soledad	Terapia de Autonomía
Obs.-Compulsivo	Perfeccionismo rígido	Control, orden, detalle excesivo	TCC + Flexibilidad

OJO: No confundir Personalidad Obs-Compulsivo con Trastorno OC (este último es Ego-Distónico: el síntoma molesta)

Diferencias

Característica	Grupo A	Grupo B	Grupo C
-----------------------	----------------	----------------	----------------

Cómo los ven los demás	Extraños	Dramáticos	Tímidos
Emoción	Fría o inapropiada	Intensa / Inestable	Ansiosa
Relación social	Retraída	Caótica	Temor a rechazo

11 - TRASTORNOS ALIMENTARIOS

Definición: Los trastornos alimentarios son condiciones psicológicas graves relacionadas con comportamientos alimentarios persistentes, que afectan negativamente la salud física, el funcionamiento social o laboral, y el bienestar emocional. Están caracterizados por una preocupación excesiva por el peso, la figura corporal y la alimentación, lo que lleva a hábitos alimentarios extremos y perjudiciales.

Los sentimientos de insuficiencia, depresión, ansiedad, soledad, así como las dificultades en las relaciones familiares y personales, o experimentar un evento traumático también pueden contribuir a los trastornos alimentarios.

La mayoría de los trastornos alimentarios resultan de una profunda insatisfacción con el propio cuerpo, forma y peso que lleva a las personas a presentar determinados comportamientos poco saludables en relación al consumo de alimentos.

Causas de los trastornos alimenticios

Los trastornos de la conducta alimentaria son situaciones complejas que pueden ser el resultado de múltiples factores incluyendo psicológicos, socioculturales o biológicos.

Dentro de los Factores Biológicos:

- Antecedentes familiares de trastornos alimentarios aumentan el riesgo
- Desequilibrio químico
- Cambios hormonales

En los Factores Psicológicos:

- Baja autoestima
- Trastornos emocionales
- Trastornos en el control de su vida que exacerban comportamientos disfuncionales

En los Factores Socioculturales:

- Presión social
- Medios de comunicación
- Glorificación de la delgadez
- Normas culturales que fomentan estos trastornos

También influyen experiencias traumáticas, dinámicas familiares malsanas, experiencias de vida o educación sobre alimentación.

Clasificación

Los tipos más comunes son:

- Bulimia Nerviosa
- Anorexia Nerviosa
- Trastorno por Atracón
- Pica
- Trastorno de Rumiación
- Trastorno alimentario compulsivo
- Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos
- Vigorexia
- Ortorexia

BULIMIA NERVIOSA

La bulimia es una obsesión por la alimentación y el peso que se caracteriza por comilonas o atracones que se repiten en un lapso corto de tiempo, seguidas de una conducta compensatoria inapropiada, como el vómito forzado, uso excesivo de laxantes, diuréticos o el ejercicio excesivo.

Es una adicción secreta que domina los pensamientos, menoscaba la autoestima y amenaza la vida de quien lo padece.

El miedo a la grasa y los intentos de perder peso son los principales síntomas de la bulimia nerviosa.

El sentimiento de pérdida de control, seguido de culpa, es lo que conduce al acto de purgar.

El peso de la persona puede variar de normal a sobrepeso.

Es posible que la persona presente erosión del esmalte dental debido a los episodios de vómito así como problemas gastrointestinales y cicatrices en la piel de la espalda de la mano resultante de inducir al vómito, entre otros signos.

BULIMIA NERVIOSA

La mayoría de personas con bulimia son en extremo reservadas acerca de su conducta, y a veces hacen enormes esfuerzos por aparentar que comen de manera normal ante otras personas.

De cierta manera sienten vergüenza de su conducta y de lo que este trastorno ha provocado en su vida.

En síntesis: la Bulimia se caracteriza por:

- Miedo a ganar peso
- Episodios de atracones que generan culpa
- Conductas purgativas

Tipos de Bulimia

Bulimia nerviosa tipo purgativo: El paciente se provoca regularmente el vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas para controlar el peso. Entre los bulímicos, se distinguen algunos que comen con exceso y se purgan varias veces al día.

Bulimia nerviosa tipo no purgativa: El paciente, para contrarrestar los atracones, hace ejercicio en exceso, dietas restrictivas o incluso ayunos.

CARACTERÍSTICAS DE LA BULIMIA NERVIOSA

- Obsesión por el peso y su imagen corporal, siguiendo dietas estrictas y restrictivas.
- Conductas compulsivas, nerviosismo al tratar temas de alimentación o físico.
- Inestabilidad emocional e impulsividad.
- Desorden en horarios y comidas para evitar comer con la familia.
- Debilidad física y/o deshidratación.
- Posibles hemorragias intestinales.
- Erosión en las piezas dentales.
- Puede acompañar depresión o trastornos de la personalidad.
- Puede coexistir con otras adicciones o conductas nerviosas (fumar, mascar chicle).

ANOREXIA NERVIOSA

Se caracteriza por:

- Restricción extrema de la ingesta de alimentos
- Miedo intenso e irracional a ganar peso
- Distorsión de la imagen corporal

Una persona con anorexia realiza acciones extremas para controlar su peso, afectando su salud.

El bajo peso puede generar amenorrea en mujeres.

Además de pérdida de peso:

- Piel muy seca
- Caída del cabello
- Retraso en el desarrollo puberal

Subtipos:

Tipo restrictivo: Restricción alimentaria sin atracones ni purgas.

Tipo con atracones/purgas: Episodios de atracones seguidos de purgas.

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS Y SOCIALES DE LA ANOREXIA NERVIOSA

- Miedo intenso a comer en presencia de otros.
- Dietas bajas en carbohidratos y grasas.

- Preocupación por el alimento, abuso de laxantes y mentiras.
- Afecta mayormente a mujeres jóvenes influidas por modelos mediáticos.
- Pérdida significativa de peso.
- Distorsión de la imagen corporal.
- Baja autoestima.

SÍNTOMAS FÍSICOS Y ORGÁNICOS DE LA ANOREXIA NERVIOSA

Los síntomas derivan de desnutrición y deficiencia de micronutrientes.

- Ritmo cardíaco lento (bradicardia)
- Desbalance electrolítico (bajo fosfato) → debilidad muscular, inmunodeficiencia, muerte
- Retraso del crecimiento en quienes desarrollan anorexia antes de la adultez
- Disminución de hormonas esenciales, aumento del cortisol
- Osteoporosis (bajo calcio y vitamina D)
- Cambios en estructura y función cerebral por inanición

SÍNTOMAS COMPORTAMENTALES DE LA ANOREXIA NERVIOSA

- Rechazo voluntario de alimentos hipercalóricos
- Aumento de ingesta de líquidos
- Conductas alimentarias extrañas
- Disminución del sueño
- Mayor irritabilidad
- Autoagresión
- Ejercicio excesivo
- Uso de laxantes y diuréticos
- Vómitos autoinducidos
- Uso compulsivo de la balanza

SÍNTOMAS EMOCIONALES Y MENTALES DE LA ANOREXIA NERVIOSA

- Pensamiento obsesivo con peso y alimentos
- Dismorfobia
- Ansiedad, depresión, ansiedad social
- TOC y conductas agresivas
- Negación de hambre, sed, fatiga y sueño
- Negación parcial o total de la enfermedad
- Miedo a subir de peso
- Dificultad de concentración y aprendizaje
- Desinterés sexual
- Temor a perder el autocontrol
- Desinterés por actividades lúdicas
- Autodestrucción, abuso de sustancias, intentos de suicidio

SÍNTOMAS INTERPERSONALES Y SOCIALES DE LA ANOREXIA NERVIOSA

- Distanciamiento social
- Aislamiento
- Ruptura de relaciones afectivas
- Deterioro familiar
- Incapacidad para atender responsabilidades
- Inversión del día en actividades de control del peso
- Descuidar necesidades básicas: comer y dormir

Alteraciones por efecto de la inanición

- Pérdida excesiva de peso
- IMC < 17,5 en adultos o 85% del peso esperado en niños
- Aspecto pálido, ojos hundidos
- Hinchazón de ojos y tobillos
- Piel seca, labios quebradizos
- Retraso del crecimiento
- Alteraciones hormonales: amenorrea, reducción de libido, impotencia
- Alteraciones metabólicas: arritmia, bradicardia, hipotensión, hipotermia, anemia
- Caída del cabello, aparición de lanugo, uñas frágiles
- Problemas circulatorios
- Vértigo, dolor de cabeza
- Deshidratación
- Caries dentales
- Estreñimiento, dolor abdominal, edema
- Insomnio, letargo
- Infertilidad
- Anomalías en niveles minerales y electrolitos
- Depresión del sistema inmunitario
- Daño renal y hepático
- Infarto y muerte (casos graves)

TRASTORNO POR ATRACÓN

Caracterizado por:

- Ingesta desproporcionada de comida
- Sin mecanismos compensatorios (a diferencia de bulimia)
- Frecuente en personas con sobrepeso u obesidad.}equiere patrones repetidos, no episodios aislados.

Características:

- Pérdida de control durante el episodio
- Comer para sobrellevar emociones
- Problemas de salud asociados: diabetes, HTA, triglicéridos elevados

Frecuente comorbilidad con:

- Depresión
- Ansiedad

- Aislamiento social

SÍNTOMAS BÁSICOS DEL TRASTORNO POR ATRACÓN

- Comer cantidades excesivas
- Sensación de no poder controlar lo que se come
- Comer rápido
- Comer hasta sentirse incómodamente lleno
- Comer sin hambre
- Comer a solas por vergüenza
- Culpa o depresión tras atracón
- Cambios de peso
- Baja autoestima
- Pérdida de deseo sexual
- Dietas frecuentes

PICA

Ingesta persistente y compulsiva de sustancias no alimentarias sin valor nutritivo.

- Puede causar obstrucciones o intoxicación por plomo
- Frecuente en niños pequeños
- En mayores de 5 años indica conducta inapropiada
- Frecuente en adultos con discapacidad intelectual
- Asociada a deficiencia de hierro
- También en embarazadas

Puede coexistir con trastornos mentales como TOC

SÍNTOMAS BÁSICOS DE LA PICA

- Deficiencia mineral (hierro, zinc)
- Uñas y cabello poco saludables
- Pérdida de peso

Puede aparecer como respuesta al estrés o uso de ciertos medicamentos (neurolépticos, inhibidores dopaminérgicos).

La desnutrición o hambre puede causar búsqueda de objetos no alimentarios para sensación de saciedad.

Ejemplos de sustancias ingeridas y síntomas:

- Arena, tierra: dolor gástrico, sangrado, parásitos
- Cabello, uñas: estreñimiento o diarrea
- Papel, crayolas: obstrucción intestinal
- Hielo: desgaste dental
- Astillas de pintura: intoxicación por plomo

TRASTORNO DE RUMIACIÓN: Consiste en regurgitación y nueva masticación del alimento ingerido.

- La comida vuelve a la boca sin náuseas ni arcadas.
- Puede ser tragada nuevamente o escupida
- Ocurre durante ≥ 1 mes
- Más frecuente en niños
- También en personas con retraso mental
- Asociado a estrés o ansiedad
- Puede coexistir con autoestimulación: Balanceo, succión de dedos

SÍNTOMAS BÁSICOS DE LA RUMIACIÓN

- Regurgitación repetitiva
- Remasticación repetitiva
- Persistencia ≥ 1 mes
- Indigestión, dolor estomacal
- No produce náuseas ni desagrado
- Problemas dentales
- Pérdida de peso
- Labios agrietados

TRASTORNO DE EVITACIÓN/RESTRICCIÓN DE LA INGESTIÓN DE ALIMENTOS: Consiste en evitar o reducir significativamente la cantidad de alimentos ingeridos.

Se manifiesta por:

- Pérdida de peso significativa
- Falta de aumento de peso esperado (niños)
- Deficiencia nutritiva significativa
- Dependencia de suplementos o alimentación enteral
- Interferencia en el funcionamiento psicosocial

Ejemplo:

- Falta de interés por comer
- Evitación por características organolépticas
- Temor a consecuencias desagradables de comer

VIGOREXIA: Trastorno mental no estrictamente alimentario, también llamado complejo de Adonis.

- Obsesión por estado físico
- Ingesta exagerada de proteínas/carbohidratos

- Uso de esteroides anabólicos
- Percepción distorsionada del cuerpo (sentirse poco musculado)
- Ejercicio excesivo
- Abandono social, académico y laboral

Afecta principalmente a hombres entre 18 y 35 años.

Síntomas más comunes de la vigorexia

- Mirarse constantemente en el espejo
- Compararse con otros cuerpos
- Estrés al saltar entrenamiento o comidas
- Obsesión por ingerir suficientes proteínas
- Descuidar relaciones o trabajo
- Ejercicio como prioridad extrema

¿Cómo se diagnostica la vigorexia?

Se diagnostica cuando se observan uno o más:

- Priorizar ejercicio y dieta sobre todo
- Miedo a mostrar el cuerpo
- Aislamiento social
- Pérdida del trabajo por dedicación excesiva al Ejercicio
- Ejercicio pese a lesiones
- Uso de esteroides anabólicos

ORTOREXIA: Alteración de la conducta alimentaria por obsesión patológica con la comida sana.

- Aislamiento social
- Preocupación excesiva por calidad de alimentos
- Ausencia de placer al comer
- Planificación obsesiva
- Culpa si no se cumple la dieta
- Riesgo nutricional: desnutrición, anemia, hipervitaminosis o hipovitaminosis
- Puede causar Hipotensión y Osteoporosis

12 TRASTORNOS PSICÓTICOS

PSICOSIS

- Es un conjunto de trastornos que tienen como alteración principal la desviación del juicio y debido a esta desviación se van alterando todas las funciones mentales que darán el conjunto de psicopatologías que pueden producir una psicosis.
- La psicosis es un **trastorno mental** caracterizado por una alteración significativa de la percepción y la realidad. Las personas que padecen psicosis pueden experimentar dificultades para distinguir lo que es real de lo que no lo es, afectando su pensamiento, emociones y comportamiento.

TIPOS DE PSICOSIS

1. Esquizofrenia
2. Trastorno Delirante Persistente (Trastorno Paranoide o Paranoia)
3. Psicosis Orgánicas
4. Psicosis Breves
5. Psicosis Esquizoafectivas
6. Psicosis Esquizofreniforme
7. Psicosis Puerperal (Psicosis post-parto)

SÍNTOMAS BÁSICOS DE LA PSICOSIS

- Desviación del Juicio
- Ilusiones
- Alucinaciones
- Delirios
- Ideas Obsesivas
- Trastornos de la Forma del Pensamiento
- Taquipsiquia
- Fuga de Ideas
- Estereotipia Verbal
- Ecolalia
- Soliloquios
- Taquilalia
- Verborragia
- Mutismo
- Aumento O Disminución De La Atención
- Amnesias De Fijación
- Alucinación De La Memoria
- Orientación Conservada o Desorientación Temporal y en Persona
- Inquietud o Agitación Psicomotriz
- Ecopraxia
- Estereotipia Motora
- Síntomas Motores Catatónicos
- Manierismos
- Agresividad
- Temblores
- Distonías
- Mioclonías
- Aplanamiento Afectivo

- Ambivalencia Afectiva
- Ansiedad Extrema
- Miedo
- Manía
- Depresión
- Neotimias
- No Conciencia de Enfermedad
- Neologismo
- Aislamiento
- Percepción Delirante
- Insomnio
- Abandono de la Higiene y Cuidado Personal
- Deterioro Académico, Social y Laboral

ESQUIZOFRENIA

- La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta.
- Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad, lo que puede ser angustioso para ellas, sus familiares y amigos.
- Es más frecuente en adolescentes o adultos jóvenes (de 15 a 45 años).
- Prevalencia entre 0,7 a 1,2 % de la población mundial.
- No hay diferencias por sexo, excepto en los subtipos que si pueden tener diferencias.
- Es la más frecuente de las psicosis y la que más requiere de internación.
- Es una enfermedad crónica y recidivante.
- Predisposición genética.

¿QUÉ CAUSA LA ESQUIZOFRENIA?

Factores genéticos:

- A veces, la esquizofrenia es hereditaria.
- Alteraciones bioquímicas.
- Daño adquirido en estructuras cerebrales → anomalías en el neurodesarrollo.
- Muchos genes aumentan probabilidad, pero ninguno por sí solo causa el trastorno.

Ambiente: Factores ambientales pueden incluir pobreza, estrés, entornos peligrosos, exposición a virus o problemas nutricionales prenatales.

Estructura y función cerebral:

- Diferencias en tamaño y conexiones de áreas cerebrales.
- Algunas diferencias se desarrollan antes del nacimiento.

¿CON QUÉ SÍNTOMAS SE MANIFIESTA LA ESQUIZOFRENIA?

Síntomas positivos:

- Experiencias extrañas y fenómenos no normales.
- Alucinaciones (predominantemente auditivas).
- Delirios, pensamientos extraños, desconfianza.
- Distorsión de la realidad.

Síntomas negativos:

- Emociones aplanadas.
- Falta de motivación (abulia, apatía).
- Anhedonia.
- Lenguaje escaso o pobre (alogia).

Síntomas de desorganización:

- Pensamiento confuso, lenguaje incoherente.
- Conducta emocional inadecuada.
- Comportamientos extraños.

FASES O ETAPAS DE LA ESQUIZOFRENIA

Periodo Prodrómico:

- Transición donde aparecen síntomas iniciales.
- Predominan síntomas negativos.
- Puede durar meses o años.

Signos:

- ✓ Aislamiento social
- ✓ Abandono escolar
- ✓ Ideas de referencia

- ✓ Ilusiones (signo del espejo)
- ✓ Ambivalencia y aplanamiento afectivo
- ✓ Miedo
- ✓ Abandono de higiene
- ✓ Insomnio

Periodo del Brote Psicótico:

- Aparición de síntomas positivos.

Incluye:

- ✓ Desviación del juicio
- ✓ Agitación o síntomas catatónicos (Flexibilidad Cérea - Postura extrema - Negativismo - Obediencia Automática)
- ✓ Alucinaciones (sobre todo auditivas)
- ✓ Ilusiones y delirios
- ✓ Miedo, insomnio
- ✓ Agresividad
- ✓ Trastornos afectivos
- ✓ Soliloquios, ecolalia, verborrea (Hablar exagerado)
- ✓ Disminución de atención

Periodo Residual:

- Psicopatologías que no se resolvieron.
- Predominio de síntomas negativos.

Incluye:

- ✓ Delirios poco estructurados
- ✓ Aplanamiento afectivo
- ✓ Empobrecimiento del lenguaje
- ✓ Aislamiento
- ✓ Vagabundeo

- ✓ Abandono de higiene
- ✓ Alucinaciones sin conducta
- ✓ Poca autosuficiencia

TIPOS DE ESQUIZOFRENIA

- a) Esquizofrenia Simple
- b) Esquizofrenia Paranoide
- c) Esquizofrenia Catatónica
- d) Esquizofrenia Hebefrénica
- e) Esquizofrenia Residual

TIPOS DE ESQUIZOFRENIA

a) Esquizofrenia Simple: Se caracteriza por un deterioro progresivo en el comportamiento y la disminución en el rendimiento social y laboral, sin la presencia de síntomas psicóticos evidentes como delirios o alucinaciones.

Le caracteriza su estilo de vida esquizofrénico, su abandono social y abandono físico.

Se presenta en adultos jóvenes.

b) Esquizofrenia Paranoide: Es el subtipo más común, caracterizado principalmente por la presencia de delirios paranoides (de persecución, de daño, de grandeza) y alucinaciones auditivas, sin un deterioro notable en la afectividad ni en el comportamiento.

Se presenta por lo general entre los 25 y 40 años de edad.

c) Esquizofrenia Catatónica: Se distingue por alteraciones motoras graves (síntomas característicos de la catatonia), que pueden incluir inmovilidad, posturas extrañas, mutismo, o por el contrario, agitación motora excesiva.

d) Esquizofrenia Hebefrénica (o desorganizada): Es considerada una de las esquizofrenias de **peor pronóstico**.

Se caracteriza por el inicio temprano, normalmente en la Adolescencia o Pre-adolescencia.

Tiene una regresión generalizada importante en todos los sentidos.

Presentan:

- Comportamiento y habla desorganizada.
- Afecto inapropiado o plano.

- Dificultades para mantener un pensamiento coherente (síntomas negativos).

Hay menos Delirios y Alucinaciones en comparación con otros subtipos.

e) Esquizofrenia Residual: Se refiere a un estado en el cual los síntomas psicóticos han disminuido, pero persisten síntomas negativos como:

- Apatía
- Falta de energía
- Retraimiento social
- Disminución de la capacidad para planificar o realizar actividades cotidianas

Son las esquizofrenias con varios brotes Psicóticos que no fueron bien resueltos, dejando secuelas que constituyen este subtipo.

TRASTORNO PARANOIDE

(Trastorno Delirante Persistente, Trastorno Delirante Crónico o Paranoia)

Inicio tardío (entre los 25 y 45 años) y más aún a los 60 años, muchas veces aparece en ancianos como manifestación de inicio.

El síntoma más visible y a veces único son los delirios de distintos tipos:

- Persecutorio
- Daño
- Celotípico
- Erotomaniaco

Puede presentar alucinaciones de corta duración, siempre referidas a los contenidos delirantes.

Los delirios generan conducta (conducta bizarra, extraña, alterada).

Presentan:

- Ansiedad moderada a intensa
- Aumento de la atención y vigilancia
- Es un trastorno crónico con buena evolución con la medicación.

Sus relacionamientos interpersonales pueden darse normalmente, favoreciendo buen pronóstico.

PSICOSIS BREVES

Pueden tener todos o algunos síntomas de los diferentes tipos de psicosis, pero su característica principal es:

→ De breve duración, máximo 1 mes.

Normalmente se recupera a la 1ª semana, o a los 15 o 20 días.

La resolución es total.

Es un episodio único, sin recaídas.

Incluye psicosis generadas por:

- Trastornos de personalidad
- Adaptativas
- Por estrés

Tienen buena evolución.

En síntesis: El trastorno psicótico breve consiste en la aparición de ideas delirantes, alucinaciones u otros síntomas psicóticos que duran al menos 1 día, pero menos de 1 mes, con retorno final a la funcionalidad normal previa.

PSICOSIS ORGÁNICAS

Este tipo de Psicosis se basa en un daño orgánico determinado como causa principal.

Ejemplos:

- Encefalitis
- Tumor cerebral
- Traumatismo craneoencefálico
- Hipertiroidismo
- Lupus
- Psicosis por corticoides
- Psicosis tóxicas

Pueden presentar todos los síntomas básicos de las Psicosis.

Más frecuentes:

- Alucinaciones visuales
- Ilusiones visuales
- Desorientación en las tres esferas (Tiempo - Espacio - Persona)
- Disminución de atención y concentración
- Delirios paranoides
- Amnesias de fijación
- Insomnio
- Confusión, estupor, embotamiento mental

PSICOSIS ESQUIZO AFECTIVAS

Caracterizadas por:

- Combinación de síntomas de esquizofrenia (Alucinaciones, Delirios)
- y de trastornos del estado de ánimo (Bipolar: Depresión o Manía)

Presentación más frecuente:

- Cuadro maníaco con delirios megalomaníacos
- Alucinaciones auditivas de tipo imperativa

Importante:

Los delirios, alucinaciones y la desviación del juicio no desaparecen al resolverse el cuadro afectivo.

Duración promedio: 6 meses.

El curso puede implicar:

- Ciclos de síntomas graves
- Períodos de mejora parcial

Mejor evolución que la esquizofrenia y peor que el trastorno bipolar, por no tener periodos libres de síntomas.

Diferencias entre Esquizofrenia y Psicosis Esquizoafectivas

La psicosis esquizoafectiva se diferencia porque durante la vida del paciente aparece ≥ 1 episodio de depresión o manía.

PSICOSIS ESQUIZOFRENIFORMES

El trastorno esquizofreniforme se caracteriza por síntomas idénticos a los de la esquizofrenia, pero con duración:

≥ 1 mes pero < 6 meses

Incluyen:

- Delirios
- Alucinaciones
- Pensamiento desorganizado
- Conducta impredecible o inapropiada
- Discurso incoherente o irracional

Puede haber deterioro funcional, aunque menos severo que en esquizofrenia.

Diferencias entre esquizofrenia y psicosis esquizofreniforme

La principal diferencia es la duración:

- Esquizofreniforme → menos de 6 meses
- Esquizofrenia → 6 meses o más

PSICOSIS PUERPERAL O PSICOSIS POST-PARTO

La psicosis puerperal es una enfermedad mental severa que se manifiesta en las primeras semanas después del parto (lo más común: 1ª semana).

Se caracteriza por:

- Pérdida de contacto con la realidad
- Alucinaciones
- Delirios
- Comportamientos desorganizados
- Confusión y desorientación
- Incapacidad para distinguir lo real de lo imaginario
- Cambios extremos del ánimo (euforia ↔ depresión severa)
- Problemas de sueño
- Paranoia
- Intentos de lastimarse a sí misma o al bebé

13 TRASTORNOS SEXUALES

Salud sexual según la OMS

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.

Respuesta Sexual Humana

La respuesta sexual tiene requisitos biológicos de base, se experimenta en un contexto intrapersonal, interpersonal y cultural.

La función sexual supone una compleja interacción entre factores biológicos, socioculturales y psicológicos.

Para hablar de trastorno en cuanto a la respuesta sexual se debe descartar:

- a) Trastorno Mental
- b) Efectos de una sustancia
- c) Afección Médica (lesión de nervios pélvicos)
- d) Conflicto en la relación (violencia de pareja) u otros factores de estrés

TIPOS DE TRASTORNOS SEXUALES

- DISFUNCIONES SEXUALES

- PARAFILIAS
- DISFORIA DE GÉNERO

Disfunciones Sexuales

Las disfunciones sexuales se refieren a problemas que ocurren durante cualquier fase del ciclo de respuesta sexual (deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución) que impiden que la persona o la pareja disfruten de la actividad sexual.

Son un grupo de diversos trastornos, típicamente caracterizados por una alteración clínica significativa de la capacidad de la persona para responder sexualmente o para experimentar placer sexual.

Se pueden tener varias disfunciones sexuales a la vez y se deben diagnosticar todas las disfunciones, teniendo en cuenta factores como:

- La edad y la experiencia de la persona
- La frecuencia
- El tiempo de la disfunción
- El malestar que produce
- El efecto que produce en otras áreas de la vida de la persona

Los trastornos sexuales pueden ser de varios tipos y afectan tanto a hombres como a mujeres.

Categorización de las disfunciones sexuales en el hombre

TRASTORNO DEL DESEO SEXUAL HIPOACTIVO EN EL VARÓN

Consiste en la falta persistente de interés por realizar ningún tipo de actividad sexual.

Una persona afectada por este trastorno por lo general no tiene, o si tiene, le ocurre con muy poca frecuencia, pensamientos y fantasías sexuales, y está preocupada continuamente por ello.

La ausencia de deseo sexual no excluye el placer o la excitación, pero hace menos probable que la persona emprenda alguna actividad sexual.

El paciente, a pesar de no tener gran interés en el sexo, una vez que inicia la actividad sexual puede presentar un desempeño adecuado.

TRASTORNO ERÉCTIL

Consiste en la incapacidad para conseguir o mantener una erección con la suficiente rigidez hasta el final de la actividad sexual.

La erección del pene es insuficiente para dar inicio o completar el coito.

Se suele asociar a:

- Ansiedad sexual

- Miedo a no dar la talla y al fracaso
- Preocupaciones
- Afectación de la relación de pareja
- Problemas de autoestima y seguridad

La existencia de erecciones matutinas o durante la masturbación sirve para descartar enfermedad médica.

Disfunción eréctil psicógena: La disfunción aparece por problemas personales del hombre; sí hay erecciones matutinas y nocturnas.

Disfunción eréctil orgánica: Debida a enfermedad, fármacos o problemas de salud.

No hay erecciones matutinas y nocturnas; suele ser total (en todas las circunstancias y con cualquier pareja sexual).

Produce problemas psicológicos: ansiedad, baja autoestima, pérdida de control.

EYACULACIÓN PREMATURA (PRECOZ)

Consiste en la eyaculación tras una estimulación sexual mínima, antes, durante o poco tiempo después de la penetración y antes de que la persona lo desee, en repetidas ocasiones.

La eyaculación también se considera precoz si la erección requiere una estimulación prolongada, de manera que el tiempo entre erección suficiente y eyaculación se acorta.

La eyaculación precoz tiene sus raíces en la ansiedad.

EYACULACIÓN RETARDADA

Una de las disfunciones menos frecuentes.

Consiste en la dificultad para incitar la respuesta orgásmica masculina y de ejecutar su reflejo eyaculatorio.

El clímax masculino se presenta tardíamente o no se alcanza.

Causas de la eyaculación precoz y retardada

Causas Orgánicas

Eyaculación precoz:

- Incapacidad para distinguir la excitación
- Problemas en la próstata
- Efectos de fármacos (antihistamínicos, antipsicóticos, tratamiento para disfunción eréctil)

Eyaculación retardada:

- Obstrucción de vías seminales

- Disminución de motilidad (lesiones medulares, neuropatías diabéticas, trastornos hormonales)

Causas Psicológicas

Eyacuación precoz:

- Experiencias desagradables tempranas
- Control deficiente del orgasmo
- Ansiedad
- Miedo al fracaso
- Pensamientos distorsionados
- Complejos del pene
- Eyacuación retardada:
- Angustia
- Hipercontrol
- Evitación del orgasmo
- Búsqueda excesiva del mismo
- Poca concentración
- Ansiedad

Categorización de las disfunciones sexuales en la mujer

TRASTORNO DEL INTERÉS/EXCITACIÓN SEXUAL FEMENINO – FRIGIDEZ

Disminución o ausencia persistente de fantasías sexuales, deseo sexual o excitación durante la actividad sexual, generando malestar significativo.

Se da cuando una mujer carece de interés o no alcanza suficiente excitación.

Causas psicológicas:

- Depresión, ansiedad o estrés
- Experiencias traumáticas (abuso sexual o emocional)
- Problemas de autoestima o inseguridad corporal
- Conflictos de pareja

Causas fisiológicas y hormonales:

- Cambios hormonales (menopausia)
- Medicamentos (antidepresivos, anticonceptivos)
- Trastornos endocrinos (hipotiroidismo)
- Enfermedades crónicas

Factores socioculturales:

- Normas y creencias restrictivas
- Falta de educación sexual
- Estigmatización del deseo sexual femenino

TRASTORNO DEL DOLOR GENITO-PÉLVICO/PENETRACIÓN

Dolor genital (solo en la mujer) por el coito, especialmente durante la penetración.

VAGINISMO: Disfunción sexual caracterizada por contracción involuntaria de los músculos del tercio inferior de la vagina, dificultando o imposibilitando la penetración.

- Automático, no voluntario.
- Genera angustia y problemas sexuales.

Características:

- Contracción involuntaria en penetración, tampones o examen ginecológico.

Tipos:

Primario: Nunca hubo penetración posible.

Secundario: Aparece después de una etapa normal.

Causas del vaginismo

- Infecciones o cicatrices
- Miedo al dolor
- Traumas sexuales
- Falta de educación sexual

Síntomas:

- Dolor o imposibilidad de penetración
- Miedo intenso
- Evitación de relaciones
- Frustración personal o de pareja

DISPAREUNIA: Dolor genital recurrente durante o después del coito (más común en mujeres, pero también ocurre en hombres).

Características:

- Dolor superficial o profundo
- Puede ser intermitente o constante

Causas:

Físicas: infecciones, sequedad vaginal, cicatrices, endometriosis

Psicológicas: ansiedad, trauma, problemas de pareja

Ejemplo clínico:

Dolor punzante en la entrada vaginal → ansiedad anticipatoria → evita relaciones.

DIFERENCIAS ENTRE DISPAREUNIA Y VAGINISMO

- **Dispareunia:** La penetración es posible pero dolorosa.
- **Vaginismo:** La penetración es difícil o imposible por contracción muscular involuntaria.

Ambos pueden tratarse con:

- Terapia psicológica
- Ejercicios de relajación
- Dilatadores vaginales
- Tratamiento médico si hay causa física

TRASTORNO ORGÁSMICO FEMENINO – ANORGASMIA

Periodo normal de excitación, pero el clímax se retrasa o no se alcanza.

Factores que dificultan el orgasmo:

- Antecedentes de abuso sexual
- Aburrimiento con la actividad sexual
- Fatiga, estrés, depresión
- Falta de conocimiento de la función sexual
- Actitudes negativas hacia el sexo
- Timidez o vergüenza para pedir estímulo adecuado
- Problemas de pareja

OTRAS DISFUNCIONES SEXUALES

DISFUNCIÓN SEXUAL INDUCIDA POR SUSTANCIA/MEDICAMENTO

Debida a intoxicación o abstinencia de alcohol u otras drogas.

OTRA DISFUNCIÓN SEXUAL, ESPECIFICADA O NO ESPECIFICADA

Categoría para problemas sexuales que no cumplen criterios de otras disfunciones.

PARAFILIAS: Consisten en conductas o fantasías sexuales excitatorias frecuentes que implican:

- Objetos inanimados
- Niños o adultos sin consentimiento
- Sufrimiento o humillación propia o ajena

Los trastornos parafilicos generan:

- Angustia
- Deterioro

- Riesgo para otros

Una vez establecidos en infancia o pubertad, suelen ser persistentes de por vida.

EN SÍNTESIS:

La parafilia se caracteriza por fantasías, impulsos o conductas sexuales intensas y recurrentes con:

- Objetos no humanos
- Personas sin consentimiento
- Sufrimiento / dolor
- Humillación

CLASIFICACIÓN DE LAS PARAFILIAS – ESPECIFICADAS

- Exhibicionismo
- Voyeurismo
- Frotterismo
- Fetichismo
- Fetichismo travestista
- Pedofilia
- Sadismo sexual
- Masoquismo sexual

CLASIFICACIÓN DE LAS PARAFILIAS – NO ESPECIFICADAS

- Necrofilia
- Zoofilia
- Coprofilia
- Escatología telefónica

PARAFILIAS ESPECIFICADAS

1) EXHIBICIONISMO: Es un tipo de Parafilia que consiste en que la persona exhibe o muestra sus genitales, a cualquier persona extraña con la intención de provocar algún tipo de reacción. En ocasiones el exhibicionista no solo exhibe sus genitales, sino que además lo hace mientras se masturba.

Los exhibicionistas (por lo general de sexo masculino), exponen sus genitales a personas desconocidas y que están desprevenidas, obteniendo así excitación sexual.

Pueden ser conscientes de su necesidad de sorprender, impactar o impresionar al observador.

La víctima es casi siempre una mujer o un niño de uno u otro sexo.

Casi nunca existe un intento posterior de mantener una actividad sexual con la persona extraña por parte del exhibicionista, de modo que raramente cometen violaciones.

El exhibicionismo generalmente comienza durante la adolescencia, pero en ocasiones el primer acto puede ocurrir durante la preadolescencia o la mediana edad.

La mayoría de los exhibicionistas están casados, pero su matrimonio suele ser conflictivo.

Ejemplo: Un hombre que siente placer mostrando sus genitales a extraños en público.

2) VOYEURISMO: Es un tipo de parafilia en el cual el sujeto se excita sexualmente viendo personas desnudas u observando a otras personas coitando sin ser visto.

Excitación sexual al observar a escondidas a personas desnudas o realizando actos sexuales sin su consentimiento.

En el Voyeurismo, es el acto de mirar (espíar) el que produce la excitación y no el hecho de mantener una relación sexual con la persona observada.

Los voyeurs no buscan el contacto sexual con las personas observadas.

Cuando observan a personas sin que estas consientan, pueden tener problemas legales.

El Voyeurismo generalmente comienza durante la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta.

Es frecuente un cierto grado de Voyeurismo, con mayor frecuencia en chicos y hombres adultos, pero cada vez es más frecuente en mujeres.

Ejemplo: Alguien que espía a sus vecinos mientras están en situaciones íntimas.

3) FROTEURISMO: El frotismo (froteurismo) es una excitación sexual intensa que se produce al tocar o frotarse contra una persona de forma no consentida.

Excitación sexual al frotarse contra personas sin su consentimiento.

Esto suele implicar el contacto con una persona desconocida en áreas abarrotadas como el metro, los autobuses, los ascensores, los eventos deportivos u otros eventos públicos con mucha gente.

Muchos afectados por trastorno frotista (froteurista), llamados “frotteurs”, parecen excitarse por el riesgo de ser sorprendidos en un lugar público.

La mayoría de los casos de frotismo ocurren cuando los hombres tocan a las mujeres, aunque ha habido casos de mujeres que tocan a hombres o a mujeres o de hombres que tocan a hombres.

Ejemplo: Una persona que se frota contra desconocidos en el transporte público buscando gratificación sexual.

4) FETICHISMO: Es una de las parafilias o perversiones más frecuentes.

Los sujetos fetichistas para conseguir la excitación sexual intensa, necesitan algún objeto no sexual, el fetiche. Este puede ser una ropa interior femenina, un zapato, una media, un rizo de pelo, etc.

Los fetiches corporales más frecuentes son: pies, manos, cabello, obesidad, tatuajes y piercings.

Los objetos fetichistas más frecuentes son: zapatos, guantes y ropa interior (sucia), cuero, hule, faldas, guantes y pañales.

El fetichista generalmente sostiene, frota, prueba o huele el objeto fetiche para gratificación sexual o le pide a su pareja que use el objeto durante los encuentros sexuales.

Para algunos, simplemente una imagen del objeto fetiche puede causar excitación, aunque muchos con un fetiche prefieren (o requieren) el objeto real para lograr la excitación.

Ejemplo: Una persona que sólo puede excitarse cuando su pareja usa ciertos tipos de zapatos.

5) FETICHISMO TRAVESTISTA: Parafilia en la que el hombre logra la excitación sexual vistiéndose de mujer.

Se caracteriza porque el sujeto que lo padece se pone las ropas de otra persona del sexo opuesto porque ello le excita sexualmente, y es frecuente que se masturben cuando están travestidos.

El sujeto guarda la ropa y la utiliza sólo para vestirse cuando está solo, masturbándose con ella.

En el Fetichismo Travestista algunas personas tienen fantasías sexuales en las que simultáneamente son hombre y mujer.

No hay que confundir este trastorno con el Trastorno de la Identidad Sexual.

Ha sido descrita sólo en hombres heterosexuales.

Los varones heterosexuales que se visten con ropa de mujer suelen comenzar este tipo de comportamiento durante la segunda infancia.

Este comportamiento está asociado, al menos inicialmente, con una intensa excitación sexual.

6) PEDOFILIA: Es cuando un sujeto siente o experimenta deseo sexual o excitación sexual hacia niños o niñas prepuberales, de entre 6 a 12 años.

Los sujetos que presentan este trastorno y que «utilizan» a los niños según sus impulsos pueden limitar su actividad simplemente a desnudarlos, a observarlos, a exponerse frente a ellos, a masturbarse en su presencia o acariciarlos y tocarlos suavemente.

Otros, sin embargo, efectúan felaciones o cunnilingus, o penetran la vagina, la boca o el ano del niño con sus dedos, objetos extraños o el pene.

La pedofilia es mucho más frecuente en varones que en mujeres.

Por lo general, el pedófilo suele ser una persona que el niño conoce, como un familiar, un padrastro o una persona con autoridad (como un profesor o entrenador).

Algunos se sienten atraídos solo por los niños dentro de su propia familia (incesto).

Otros pedófilos se sienten atraídos sólo por los niños o niñas, de un rango de edad específico o una etapa de desarrollo.

Ejemplo: Un adulto que siente atracción sexual hacia menores y actúa de acuerdo a esos impulsos, lo que constituye un delito.

7) SADISMO SEXUAL: Consiste en que el sujeto se excita sexualmente con el dolor que le ocasiona a otra persona.

El sadismo sexual comporta actos en los que la persona experimenta excitación sexual al infligir sufrimiento físico o psicológico a otra persona.

La persona que padece del trastorno de sadismo sexual presenta un malestar significativo, que afecta sustancialmente al funcionamiento diario, daña a otra persona o afecta a alguien que no ha dado su consentimiento.

El sádico lleva estos actos hasta el extremo, y en algunas ocasiones provoca graves daños corporales o psicológicos o incluso la muerte.

Los actos sádicos pueden involucrar actividades que indican el dominio sobre la víctima y por lo general afectan a parejas que no dan su consentimiento.

El sadismo sexual no es sinónimo de violación, sino que se trata de una compleja mezcla de sexo y poder sobre la víctima.

8) MASOQUISMO SEXUAL: Se puede definir como un trastorno psíquico que padecen ciertos sujetos, los cuales obtienen placer sexual cuando experimentan sufrimiento.

La característica esencial del masoquismo sexual consiste en el acto (real, no simulado) de ser humillado, golpeado, atado o cualquier otro tipo de sufrimiento o maltrato.

Los actos realizados pueden causar graves daños psicológicos o corporales, e incluso la muerte, como ocurre en la asfixia autoerótica.

Los actos masoquistas pueden consistir en la restricción física, golpes, pinchazos, descargas eléctricas, humillaciones (por ejemplo ser orinado o defecado encima; ser sometido a insultos; obligado a arrastrarse como un animal, etc.).

Una forma de masoquismo es la **hipoxifilia** (comportamiento sexual en el que la persona obtiene placer mediante la limitación de su respiración, ya sea mediante asfixia parcial, sofocación o estrangulamiento).

NECROFILIA: Parafilia caracterizada por una atracción sexual hacia los cadáveres.

El sujeto que sufre de necrofilia experimenta excitación sexual o realiza actos sexuales con cadáveres, siendo esta su única fuente de excitación y orgasmo.

ZOOFILIA: Consiste en la atracción sexual o incluso la realización del acto sexual entre un ser humano y otra especie.

La bestialidad consiste en obtener el placer sexual con los animales.

Hay que poner en claro que este término no define la excitación sexual al observar la actividad sexual de los animales; se refiere específicamente a copular con ellos.

COPROFILIA: Es la atracción sexual por oler, saborear, tocar o ver el acto de defecar como único medio de excitación sexual y placer.

Esta actividad erótica se puede practicar individual o colectivamente.

ESCATOLOGÍA TELEFÓNICA: La persona se excita o siente placer sexual llamando por teléfono o celular a otra persona para hablar de forma sexual.

Comprende la excitación derivada de las llamadas telefónicas en las que se utiliza lenguaje sexual u obsceno.

DISFORIA DE GÉNERO: La disforia de género es un diagnóstico clínico que describe la profunda incomodidad, aflicción o angustia que una persona puede experimentar debido a una incongruencia entre su identidad de género (cómo se percibe a sí misma) y el sexo asignado al nacer (sexo biológico).

Es decir, cuando su sexo biológico no coincide con su identidad de género.

Esta experiencia puede causar un malestar emocional significativo y puede afectar varios aspectos de la vida de una persona, incluyendo su bienestar mental, emocional y social.

La *identidad de género* es el sentido interno y profundo de una persona de ser hombre, mujer, una mezcla de ambos, o ninguno, y puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer.

Cuando hay una discrepancia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género de una persona, esto puede llevar a experiencias de disforia de género.

La disforia de género reemplaza el término antiguo “trastorno de identidad de género” para evitar la patologización de la identidad transgénero.

Criterios Diagnósticos

El diagnóstico requiere la presencia de una incongruencia significativa entre el género experimentado y el sexo asignado al nacer durante al menos 6 meses, acompañada de angustia significativa o dificultades en la vida social, laboral o personal.

Criterios para adultos y adolescentes:

- Deseo intenso de ser del género opuesto.
- Preferencia por ser tratado como el género con el que se identifica.
- Malestar intenso con las características sexuales primarias o secundarias.
- Deseo de deshacerse de los rasgos sexuales del sexo asignado al nacer.

Criterios para niños:

- Preferencia intensa por juguetes, ropa o actividades típicas del género opuesto.
- Deseo fuerte de pertenecer al otro género o insistencia en que lo es.
- Rechazo de las características sexuales que surgen con el desarrollo.

Conceptos a tener en cuenta

Identidad sexual

- Es el patrón de los rasgos sexuales de la persona.
- Está influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales.

Identidad de género

- Es la convicción de ser varones o mujeres.
- Es la vivencia interna y personal del género, que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer.
- Las personas se identifican como hombres, mujeres, ambos, ninguno o con otra categoría (p. ej., no binario).
- Es una experiencia subjetiva y central en la construcción de la identidad personal.

Orientación sexual

- Es el objetivo de los impulsos sexuales de una persona.
- Hace referencia a la atracción emocional, romántica o sexual que una persona siente hacia otras.
- Las orientaciones más comunes son heterosexual, homosexual (gay/lesbiana), bisexual, asexual, entre otras.

Conceptos a tener en cuenta

Reasignación de género

Denota un cambio oficial (y normalmente legal) de género.

La identidad de género es una categoría de identidad social y se refiere a la identificación del sujeto como varón, mujer u, ocasionalmente, con alguna otra categoría distinta.

Es el proceso médico, legal y social mediante el cual una persona transgénero ajusta su cuerpo y/o su identidad a su género sentido.

Puede incluir intervenciones hormonales, quirúrgicas y el cambio de documentos legales.

Transgénero: Se refiere al amplio espectro de sujetos que de forma transitoria o permanente se identifica con un género diferente de su género natal.

Se refiere a las personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer.

Transexual: Denota a un sujeto que busca, o que ha experimentado, una transición social de varón a mujer o de mujer a varón, lo que en muchos casos —pero no en todos— también conlleva una transición somática mediante tratamiento continuo con hormonas del sexo opuesto y cirugía genital (cirugía de reasignación sexual).

Es un término que hace referencia a aquellas personas que deciden modificar su cuerpo mediante procedimientos médicos y/o quirúrgicos para que su cuerpo se alinee con su identidad de género.

Si bien “transexual” aún se utiliza, el término “transgénero” es más inclusivo y ampliamente aceptado actualmente.

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA	FUNDAMENTO BREVE
1	Placer al mirar sin consentimiento	Voyeurismo	Excitación al observar en secreto.
2	Falta de interés sexual	Deseo Sexual Hipoactivo	Disminución persistente del deseo.
3	Trastorno de la Excitación Sexual	Disfunción eréctil	Incapacidad de lograr o mantener erección.
4	Placer al hacer sufrir al otro	Sadismo	Excitación por causar dolor o humillación.
5	Uso de objetos para excitarse	Fetichismo	Objeto inanimado o parte corporal no genital.
6	No alcanza el orgasmo	Anorgasmia	Falta de clímax pese a la excitación.
7	No puede mantener la erección	Disfunción Eréctil	Problema en la fase de excitación.
8	Mostrar los genitales a extraños	Exhibicionismo	Excitación al Exhibirse.
9	Dolor durante el Acto Sexual	Dispareunia	Dolor genital o pélvico en la relación.
10	Interés por Pies de la Pareja	Fetichismo	Excitación por objetos o partes no sexuales.